

Banco de preguntas de Microbiología II

Versión V4.22 - 338 preguntas organizadas por bloque. Incluye Virología ampliada, Parasitología, Artrópodos y Serpientes.

Índice de bloques

Nº	Área	Bloque	Preguntas
1	Virología	Generalidades de Virología	21
2	Virología	Herpesvirus: VHS, VVZ, VEB, CMV, VHH-6, VHH-7 y VHH-8	45
3	Virología	Papilomavirus	33
4	Virología	Adenovirus	31
5	Virología	Parvovirus y Poxvirus	38
6	Virología	Picornavirus	10
7	Virología	Orthomixovirus y Reovirus	10
8	Virología	Paramixovirus	10
9	Virología	Rhabdovirus	10
10	Virología	Togavirus y Flavivirus	10
11	Virología	Retrovirus	10
12	Parasitología	Generalidades, huéspedes y prevención	10
13	Parasitología	Paludismo	10
14	Parasitología	Trypanosoma	10
15	Parasitología	Toxoplasma gondii	10
16	Parasitología	Leishmania	10
17	Parasitología	Protozoarios intestinales y urogenitales	10
18	Parasitología	Nematodos intestinales	10
19	Parasitología	Cestodos	10
20	Parasitología	Trematodos	10
21	Artrópodos	Artrópodos de importancia médica	10
22	Serpientes	Importancia médica de serpientes	10

1. Microbiología - Virología - Generalidades de Virología

Virología · 21 preguntas · Fuente: UNIDAD 1 - Generalidades (1).pdf

1. Un alumno afirma que un virus clínicamente importante puede llevar ADN y ARN al mismo tiempo. Según las generalidades de virología, cuál corrección es la más adecuada?

- A) Puede llevar ambos si posee envoltura lipídica.
- B) Puede llevar ambos durante la fase de eclipse.
- C) Su genoma es de ADN o de ARN, pero no de ambos.
- D) El ARN aparece solo en virus de cápside desnuda.
- E) El ADN aparece solo en virus con simetría helicoidal.

2. Si un virion conserva infectividad después de desecación, ácido gástrico y detergentes, que rasgo estructural lo explica mejor?

- A) Cápside desnuda proteica.
- B) Envoltura con glucoproteínas.
- C) Genoma segmentado.
- D) Transcriptasa inversa.
- E) Simetría compleja.

3. En un esquema básico, capsómeros de polipeptidos que rodean el ácido nucleico forman la cápside. Como se denomina el conjunto cápside más ácido nucleico?

- A) Envoltura viral.
- B) Peplómero viral.
- C) Cuerpo de inclusión.
- D) Viroplasma.
- E) Nucleocápside.

4. Durante el diagnóstico de una infección viral aguda, se busca detectar directamente material genético del virus. Qué técnica corresponde mejor a ese objetivo?

- A) Prueba de coagulasa.
- B) PCR o RT-PCR.
- C) Prueba de ureasa.
- D) Coprocultivo bacteriano.
- E) Tinción de Gram.

5. La envoltura viral suele relacionarse con una mayor fragilidad ambiental. Qué consecuencia práctica se espera?

- A) Mayor resistencia a bilis.
- B) Mayor tolerancia a desecación.
- C) Mayor estabilidad en aguas residuales.
- D) Mayor sensibilidad a detergentes.
- E) Mayor resistencia a pH ácido.

6. Un virus causa enfermedad por destruir células durante su replicación. Qué término general describe mejor ese efecto?

- A) Citólisis viral.
- B) Latencia antigenica.
- C) Tolerancia humoral.
- D) Recombinación bacteriana.
- E) Antagonismo fúngico.

7. ¿Cuál combinación relaciona mejor estructura y conducta biológica viral?

- A) Envoltura - resistencia extrema a ácido.
- B) Cápside desnuda - mayor fragilidad ambiental.
- C) Envoltura - sensibilidad a solventes lipídicos.
- D) ARN - imposibilidad de variación genética.
- E) ADN - transmisión solo vectorial.

8. Si un virus no produce energía por sí mismo y necesita maquinaria celular, que propiedad está siendo destacada?

- A) Es una célula procariota atípica.
- B) Es un hongo intracelular facultativo.
- C) Es una bacteria sin pared celular.
- D) Es un protozoo con metabolismo reducido.
- E) Es un parásito intracelular obligado.

9. En la secuencia general de replicación, que evento ocurre después de la unión/penetración y antes de la síntesis de nuevos componentes?

- A) Formación de anticuerpos IgG.
- B) Liberación del genoma viral.
- C) Eliminación renal del virión.
- D) Producción de exotoxinas.
- E) Encapsulación por eosinófilos.

10. Un informe integra transmisión respiratoria, fecal-oral, sexual, vectorial y zoonótica. ¿Qué enfoque del curso resume mejor esa lista?

- A) Fases morfológicas de protozoarios.
- B) Tipos de inmunidad bacteriana.
- C) Etapas de esporulación fúngica.
- D) Vías epidemiológicas de virus estudiados.
- E) Clases de antibióticos betalactámicos.

11. ¿Cuál es una característica fundamental de los genomas víricos según su composición de ácidos nucleicos?

- A) Contienen ADN o ARN, pero no ambos tipos de ácido nucleico.
- B) Carecen de ácido nucleico y se replican mediante proteínas estructurales.
- C) Pueden contener tanto ADN como ARN en una misma partícula.
- D) El genoma siempre es una cadena doble de ADN circular.

12. ¿Qué unidad de medida se utiliza habitualmente para determinar el tamaño de un virión?

- A) Nanómetros (nm)
- B) Micrómetros (μm)
- C) Milímetros (mm)
- D) Angstroms (Å)

13. Se define como nucleocápside a la estructura formada por:

- A) La envoltura lipídica y las glucoproteínas externas.
- B) El conjunto de capsómeros antes de unirse al genoma.
- C) La membrana plasmática de la célula que rodea al virus.
- D) El ácido nucleico asociado a la cápside proteica.

14. ¿En qué lugar de la célula hospedadora ocurre generalmente la replicación de los virus ADN?

- A) Núcleo
- B) Retículo endoplásmico
- C) Aparato de Golgi
- D) Citoplasma

15. ¿Qué término describe el periodo en el que un virus está presente en el cuerpo pero en estado de reposo, sin multiplicarse ni producir síntomas?

- A) Infección lítica
- B) Periodo de eclipse
- C) Periodo de latencia
- D) Fase prodrómica

16. En el contexto de la citopatogenia, una infección transformadora se caracteriza por:

- A) La replicación viral continua a niveles muy bajos sin matar la célula.
- B) El fracaso total de la entrada del virus a la célula diana.
- C) La muerte rápida de la célula por lisis.
- D) La integración o persistencia del virus que induce una proliferación celular descontrolada.

17. ¿Cuál es el mecanismo de liberación más común para los virus que poseen envoltura?

- A) Difusión simple
- B) Lisis celular
- C) Gemación
- D) Endocitosis inversa

18. ¿Qué familia de virus posee un genoma de ARN segmentado y causa la gripe?

- A) Picornaviridae
- B) Coronaviridae
- C) Retroviridae
- D) Orthomyxoviridae

19. ¿Cuál de las siguientes técnicas se considera el estándar actual para detectar genomas de ARN viral?

- A) Hibridación in situ (FISH)
- B) Microscopía electrónica
- C) RT-PCR (PCR con transcriptasa inversa)
- D) PCR convencional

20. ¿Cuál de estos virus es un ejemplo de virus ADN con cápside desnuda (sin envoltura)?

- A) Herpesvirus
- B) Adenovirus
- C) Hepadnavirus
- D) Poxvirus

21. Los síntomas iniciales e inespecíficos como fiebre, cefalea o dolor corporal que preceden a los síntomas graves se denominan:

- A) Recidiva
- B) Viremia
- C) Pródromos
- D) Resolución

2. Microbiología - Virología - Herpesvirus: VHS, VVZ, VEB, CMV, VHH-6, VHH-7 y VHH-8

Virología · bloque combinado · Herpes simple, varicela-zóster, VEB, CMV y otros herpesvirus. · 45 preguntas

1. Una paciente presenta lesiones vesiculares recurrentes en la misma zona. Qué propiedad del VHS explica mejor estas recurrencias?

- A) Latencia en ganglios sensoriales.
- B) Mutación diaria de la cápside.
- C) Eliminación completa del genoma.
- D) Replicación exclusiva en eritrocitos.
- E) Resistencia por cápside desnuda.

2. Para iniciar una infección por VHS, que condición de entrada es más coherente con su patogenia?

- A) Eritrocito maduro intacto.
- B) Hepatocito sin receptor.
- C) Hueso cortical compacto.
- D) Cartilago articular sano.
- E) Piel o mucosa lesionada.

3. En la replicación de herpes simple, las proteínas beta se relacionan principalmente con:

- A) Ensamble tardío de cápside.
- B) Replicación del ADN viral.
- C) Bloqueo de la fusión celular.
- D) Formación de ooquistes.
- E) Maduración en mosquito.

4. Un niño desarrolla varicela y años después herpes zoster.Cuál secuencia biológica es la más correcta?

- A) Infección intestinal, quiste y excisión.
- B) Bacteriemia primaria, endospora y toxina.
- C) Viremia nula, eliminación total y reinfección.
- D) Primoinfección respiratoria, latencia y reactivación.
- E) Vectorización, esporozoito y merozoito.

5. El virus varicela-zoster comparte con los herpesvirus la capacidad de:

- A) Establecer infección persistente de por vida.
- B) Vivir libremente fuera de células.
- C) Formar huevos en heces humanas.
- D) Replicarse solo en citoplasma sin núcleo.
- E) Tener ARN segmentado negativo.

6. Un paciente inmunodeprimido con VHS tiene riesgo aumentado de cuadros graves porque estos virus:

- A) Nunca reactivan en inmunidad normal.
- B) Son siempre benignos en todo hospedador.
- C) Pueden producir morbilidad significativa.
- D) No inducen infección latente.
- E) Carecen de tropismo tisular.

7. Qué hallazgo citológico apoya una infección por herpesvirus, aunque no distingue con precisión el tipo viral?

- A) Huevos mamelonados.
- B) Larvas filariformes.
- C) Quistes con cuatro núcleos.
- D) Eritrocitos parasitados en anillo.
- E) Células gigantes multinucleadas.

8. En herpes simple, la zona de latencia más característica corresponde a:

- A) Macrófagos esplénicos.
- B) Neurona de ganglio sensorial.
- C) Hepatocito periportal.
- D) Eritroblasto medular.
- E) Queratinocito cornificado.

9. Cuál afirmación compara mejor VHS-1 y VHS-2?

- A) No comparten ADN ni antígenos.
- B) Ambos son virus ARN envueltos.
- C) Solo VHS-2 puede permanecer latente.
- D) Comparten características, pero difieren en patrones clínicos frecuentes.
- E) Solo VHS-1 se replica en núcleo.

10. En una sospecha de encefalitis herpética, la herramienta diagnóstica directa más útil para LCR suele ser:

- A) Hemocultivo anaerobio.
- B) Cinta adhesiva perianal.
- C) PCR para ADN viral.
- D) Gota gruesa de malaria.
- E) Búsqueda de huevos operculados.

11. Un adolescente con fiebre, faringitis, adenopatías y linfocitos atípicos tuvo contacto íntimo por saliva. ¿Qué virus encaja mejor?

- A) Citomegalovirus.
- B) Virus herpes humano 8.
- C) Adenovirus entérico.
- D) Parvovirus B19.
- E) Virus Epstein-Barr.

12. La mononucleosis infecciosa por VEB se interpreta como resultado principalmente de:

- A) Lisis de eritrocitos por toxina preformada.
- B) Una respuesta T intensa contra linfocitos B infectados.
- C) Migración larvaria hacia pulmón.
- D) Destrucción directa de hepatocitos por ooquistes.
- E) Replicación viral exclusiva en neutrófilos.

13. En VEB, ¿qué célula es clave como diana y zona de latencia?

- A) Eritrocito maduro.
- B) Neurona motora.
- C) Miocito esquelético.
- D) Linfocito B.
- E) Célula parietal gástrica.

14. Un paciente inmunodeficiente con VEB presenta riesgo especial de:

- A) Neoplasias y leucoplasia vellosa oral.
- B) Tos ferina y bronquiolitis neonatal.
- C) Larva migrans ocular por nematodo.
- D) Hidatidosis hepática multivesicular.
- E) Anemia por uncinarias.

15. Qué cuadro se asocia con VHH-6/VHH-7 en la infancia?

- A) Rabia furiosa.
- B) Condiloma acuminado.
- C) Exantema subit.
- D) Fiebre amarilla urbana.
- E) Parálisis flácida poliomielítica.

16. La asociación clínica más característica de VHH-8 es:

- A) Eritema infeccioso.
- B) Panencefalitis esclerosante.
- C) Gastroenteritis por rotavirus.
- D) Quiste hidatídico.
- E) Sarcoma de Kaposi.

17. CMV congénito debe sospecharse con mayor atención cuando existe:

- A) Ingestión de pescado crudo con B12 baja.
- B) Infección materna y daño fetal compatible.
- C) Mordedura de perro con hidrofobia.
- D) Prurito anal nocturno familiar.
- E) Piodermitis por estreptococo.

18. En CMV, que hallazgo histológico clásico orienta el diagnóstico?

- A) Huevos con espina lateral.
- B) Trofozoitos con eritrocitos ingeridos.
- C) Capsídeo desnuda en forma de bala.
- D) Inclusiones intranucleares en ojo de buho.
- E) Larvas en cinta adhesiva.

19. Una mononucleosis con anticuerpos heterófilos negativos puede relacionarse con:

- A) Rabdovirus.
- B) Dengue primario.
- C) Citomegalovirus.
- D) Fasciola hepática.
- E) Taenia saginata.

20. ¿Cuál combinación es más correcta?

- A) VEB - saliva - linfocito B.
- B) CMV - mosquito - hepatocito exclusivo.
- C) VHH-8 - agua - enterocito.
- D) VHH-6 - carne cruda - músculo.
- E) VEB - garrapata - eritrocito.

21. ¿Cuál es el sitio primario de latencia para el Virus de Epstein-Barr (VEB) según la fisiopatología descrita?

- A) Células epiteliales de la bucofaringe
- B) Monocitos
- C) Linfocitos T protectores
- D) Linfocitos B

22. En el contexto de la patogenia del VEB, ¿qué fenómeno explica la aparición de la mononucleosis infecciosa?

- A) La lisis directa de todas las células epiteliales infectadas
- B) Una respuesta inmunitaria hiperactiva de los linfocitos T
- C) Una respuesta inmunitaria ausente o ineficaz
- D) La producción exclusiva de anticuerpos heterófilos

23. ¿Qué característica morfológica define a las células de Downey observadas en frotis citológicos de pacientes con mononucleosis?

- A) Células epiteliales con aspecto vellosa en la cavidad bucal
- B) Cuerpos de inclusión basófilos en forma de 'ojo de búho'
- C) Linfocitos T con citoplasma basófilo y vacuolado con núcleo ovalado
- D) Linfocitos B monoclonales con mandíbula deformada

24. ¿Cuál es la tríada clásica de síntomas que presenta un paciente con mononucleosis infecciosa?

- A) Linfadenopatía, esplenomegalia y faringitis exudativa
- B) Fiebre súbita, convulsiones y exantema generalizado
- C) Microcefalia, ictericia y calcificación intracerebral
- D) Fatiga crónica, cefalea y diarrea persistente

25. En pacientes con SIDA, ¿cuál es la manifestación oportunista del VEB que afecta específicamente a las células epiteliales de la boca?

- A) Leucoplasia vellosa oral
- B) Linfoma de Burkitt
- C) Retinitis por VEB
- D) Carcinoma nasofaríngeo

26. ¿Cuál es el principal vector o vía de transmisión del Citomegalovirus (CMV) mencionado como el más relevante?

- A) Saliva
- B) Aerosoles respiratorios
- C) Semen
- D) Lágrimas

27. ¿Qué hallazgo histológico es patognomónico de la infección por CMV y constituye su efecto citopatológico (ECP)?

- A) Células epiteliales con inclusiones intracitoplasmáticas filamentosas
- B) Célula citomegálica con cuerpo de inclusión intranuclear en 'ojo de búho'
- C) Presencia de linfocitos de Downey
- D) Linfocitos B policlonales en proliferación

28. ¿Cuál es la causa vírica más frecuente de anomalías congénitas según el material de estudio?

- A) Virus de la Malaria
- B) Citomegalovirus (CMV)
- C) Virus Herpes Humano 6 (VHH-6)
- D) Virus de Epstein-Barr (VEB)

29. ¿En qué tipo de células establece su latencia el Citomegalovirus (CMV)?

- A) Células epiteliales y endoteliales
- B) Monocitos y linfocitos
- C) Linfocitos B únicamente
- D) Neuronas sensoriales

30. En recién nacidos prematuros, ¿cuál es el riesgo principal tras recibir transfusiones de sangre contaminadas con CMV?

- A) Neumonía y hepatitis
- B) Convulsiones febriles
- C) Pérdida auditiva bilateral
- D) Sarcoma de Kaposi

31. La roséola o exantema súbito es causada por la infección de qué virus específicos?

- A) VHS-1 y VHS-2
- B) VHH-8 únicamente
- C) VHH-6B y VHH-7
- D) VEB y CMV

32. ¿Qué síntoma es un factor de 'atención' importante en la infección por VHH-6 durante la infancia (6-24 meses)?

- A) Linfoma africano
- B) Rotura del bazo
- C) Ceguera por retinitis
- D) Convulsiones febriles

33. ¿Cómo se describe el exantema característico de la roséola súbita?

- A) Vesículas dolorosas en dermatomas específicos
- B) Exudado blanquecino en la faringe con fatiga extrema
- C) Pápulas umbilicadas que pican intensamente
- D) Llagas pequeñas ligeramente elevadas de color rosa sin prurito

34. ¿Cuál es la recomendación preventiva para la mononucleosis en cuanto al contacto con el virus en etapas tempranas de la vida?

- A) Aislamiento total de los niños para evitar la infección latente
- B) Vacunación obligatoria antes de los 2 años
- C) Favorecer el contacto temprano ya que la enfermedad es benigna o subclínica en niños
- D) Administración de ganciclovir profiláctico en guarderías

35. En el diagnóstico de laboratorio para mononucleosis, ¿qué técnica se reserva exclusivamente para casos graves?

- A) Aislamiento viral en cultivo
- B) Prueba de anticuerpos heterófilos
- C) Citología de linfocitos atípicos
- D) Sondas de ADN y PCR

36. ¿Cuál es la principal complicación neurológica mencionada que puede surgir de una mononucleosis infecciosa?

- A) Retraso mental profundo
- B) Síndrome de Guillain-Barré y meningoencefalitis
- C) Sordera unilateral
- D) Convulsiones febriles

37. Respecto al Linfoma de Burkitt, ¿en qué población geográfica y bajo qué condición coadyuvante es endémico?

- A) Niños en África con malaria
- B) Pacientes con SIDA en Europa
- C) Neonatos en América con CMV
- D) Adultos en Asia con carcinoma nasofaríngeo

38. Si un paciente con mononucleosis presenta síntomas por más de 4 semanas, ¿cómo se clasifica el cuadro?

- A) Enfermedad linfoproliferativa mortal
- B) Recidiva latente
- C) Cuadro crónico
- D) Infección lítica aguda

39. ¿Cuál es la diferencia principal entre la infección primaria y la recidiva de CMV durante el embarazo?

- A) Ambas tienen el mismo riesgo de malformaciones
- B) Solo la recidiva se transmite por vía ascendente
- C) La infección primaria es extremadamente grave para el feto
- D) La recidiva siempre causa microcefalia

40. ¿Qué secreción corporal se identifica como la vía de transmisión para el VHH-6 y VHH-7?

- A) Leche materna únicamente
- B) Sangre y derivados
- C) Orina y lágrimas
- D) Secreciones bucales (saliva y aerosoles)

41. ¿En qué grupo de pacientes el CMV causa frecuentemente esofagitis y colitis?

- A) Ancianos con mononucleosis
- B) Mujeres embarazadas seropositivas
- C) Niños sanos en edad escolar
- D) Pacientes con SIDA

42. ¿Qué porcentaje de adultos suele tener presente el VHH-6 en su saliva?

- A) La mayoría de los adultos
- B) Solo aquellos que trabajan en hospitales
- C) Menos del 10%
- D) Únicamente adultos con SIDA

43. En el diagnóstico diferencial, ¿qué distingue a la mononucleosis por CMV de la causada por VEB?

- A) El CMV no causa fiebre ni fatiga
- B) La mononucleosis por CMV es negativa a anticuerpos heterófilos
- C) El VEB no produce linfocitosis
- D) Solo el VEB se transmite por la saliva

44. Respecto a las enfermedades linfoproliferativas por VEB, ¿qué ocurre en sujetos que carecen totalmente de inmunidad celular?

- A) Desarrollan inmunidad natural permanente sin síntomas
- B) Pueden padecer una enfermedad policlonal de linfocitos B potencialmente mortal
- C) El virus no puede infectarlos al no haber linfocitos T
- D) Sufren únicamente de faringitis leve recurrente

45. ¿Cuál es la principal forma de prevenir la transmisión de la mononucleosis infecciosa?

- A) Evitar compartir objetos personales como cepillos de dientes y vasos
- B) Uso de mascarillas N95 en lugares públicos
- C) Tratamiento profiláctico con aciclovir a toda la población
- D) Vacunarse anualmente durante la adolescencia

3. Microbiología - Virología - Papilomavirus

Virología · 33 preguntas · Fuente: Unidad 3 Papilomavirus.pdf

1. La estructura que mejor describe al HPV es:

- A) ARN segmentado con envoltura.
- B) ADN circular bicatenario sin envoltura.
- C) ARN negativo helicoidal con envoltura.
- D) ADN monocatenario envuelto.
- E) ARN bicatenario con doble cápside.

2. Un virus que infecta queratinocitos del estrato espinoso y produce verrugas corresponde mejor a:

- A) Rotavirus.
- B) Rabdovirus.
- C) Citomegalovirus.
- D) Papilomavirus humano.
- E) Plasmodium.

3. La latencia local del HPV se relaciona principalmente con:

- A) Queratinocito infectado.
- B) Neurona de ganglio dorsal.
- C) Linfocito B de memoria.
- D) Eritroblasto medular.
- E) Hepatocito periportal.

4. Qué asociación entre genotipo y riesgo clínico es más adecuada?

- A) HPV 6/11 - alto riesgo cervical.
- B) HPV 1 - sarcoma de Kaposi.
- C) HPV 16/18 - cáncer cervical.
- D) HPV 2 - encefalitis necrosante.
- E) HPV 5 - paludismo grave.

5. El mecanismo oncogénico del HPV de alto riesgo se explica mejor por:

- A) Producción de neurotoxina salival.
- B) Destrucción de eritrocitos por merozoitos.
- C) Bloqueo de canales de sodio bacterianos.
- D) Formación de huevos en vía biliar.
- E) Inactivación de p53 y Rb por proteínas virales.

6. Un condiloma acuminado genital se asocia con más frecuencia a:

- A) Adenovirus urinario.
- B) HPV mucoso de bajo riesgo.
- C) Virus de la rabia.
- D) Toxoplasma tisular.
- E) Diphyllbothrium.

7. Cuál vía de adquisición es más coherente con HPV mucoso genital?

- A) Inhalación en cuevas.
- B) Picadura de Anopheles.
- C) Ingestión de berro acuático.
- D) Contacto sexual directo.
- E) Mordedura de perro.

8. Una razón por la cuál la infección por HPV puede persistir es que:

- A) El virus destruye siempre todo el epitelio basal en horas.
- B) El virus no infecta células humanas.
- C) La infección se mantiene localizada y protegida de la respuesta inmune.
- D) La replicación ocurre solo en eritrocitos circulantes.
- E) La cápside tiene envoltura muy frágil.

9. El método preventivo más relevante frente a lesiones malignas asociadas a HPV es:

- A) Vacunación contra tipos oncogénicos.
- B) Suero antiofídico polivalente.
- C) Cloración única del agua.
- D) Quimioprofilaxis antimalaria universal.
- E) Cinta adhesiva perianal.

10. En una prueba de tamizaje cervical, el hallazgo que hace pensar en infección por HPV es:

- A) Cuerpos de Negri.
- B) Células falciformes.
- C) Huevos mamelonados.
- D) Amastigotes en macrófagos.
- E) Koilocitosis.

11. ¿Cuál es la conformación estructural del genoma de los papilomavirus humanos?

- A) ADN lineal monocatenario
- B) ADN circular bicatenario
- C) ARN circular bicatenario
- D) ADN lineal bicatenario

12. ¿En qué capa específica de la piel se produce principalmente la replicación activa del VPH?

- A) Estrato córneo
- B) Hipodermis
- C) Estrato espinoso
- D) Dermis

13. En el diagnóstico citológico, ¿qué término describe a los queratinocitos infectados con cambios citopáticos como el citoplasma vacuolado?

- A) Células de Langerhans
- B) Células de Merkel
- C) Coilocitos
- D) Melanocitos

14. ¿Qué genotipos de VPH están más frecuentemente asociados con papilomas laríngeos y verrugas anogenitales benignas?

- A) VPH-6 y VPH-11
- B) VPH-1 y VPH-4
- C) VPH-31 y VPH-45
- D) VPH-16 y VPH-18

15. ¿Cuál es el método de elección para confirmar el genotipo específico de una infección por VPH?

- A) Inmunofluorescencia directa
- B) Citología (Papanicolaou)
- C) Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
- D) Cultivo vírico

16. ¿Qué porcentaje aproximado de las neoplasias cervicales a nivel mundial se asocian a la presencia de VPH?

- A) 30,0%
- B) 50,0%
- C) 70,0%
- D) 99,7%

17. En el contexto de la patogénesis del VPH, ¿cómo se define una neoplasia?

- A) Crecimiento descontrolado de células o tejidos anormales
- B) Infección lítica sin proliferación celular
- C) Paso previo a una alteración de la función celular
- D) Resolución espontánea de una verruga

18. ¿Cuál es la recomendación de frecuencia para el tamizaje con Papanicolaou (PAP) en una mujer con resultados previos negativos?

- A) Anual
- B) Una sola vez en la vida
- C) Cada 5 años
- D) Cada 6 meses

19. Sobre la vacuna contra el VPH, ¿cuál es una limitación fundamental mencionada en el material?

- A) No puede tratar ni curar una infección ya existente
- B) Es ineficaz si se administra antes de los 9 años
- C) Requiere una dosis única para protección de por vida
- D) Solo protege contra un único serotipo viral

20. ¿Qué factor de riesgo conductual se menciona como agravante para la progresión de la infección por VPH hacia el cáncer?

- A) Tabaquismo
- B) Dieta alta en grasas
- C) Consumo de alcohol
- D) Sedentarismo

21. ¿Cómo se conoce vulgarmente a las verrugas plantares causadas frecuentemente por el VPH?

- A) Melanoma
- B) Ojo de gallo
- C) Condiloma
- D) Pápula

22. ¿Qué tipos de VPH son responsables del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino en el mundo?

- A) VPH-1 y VPH-2
- B) VPH-16 y VPH-18
- C) VPH-6 y VPH-11
- D) VPH-31 y VPH-33

23. En el desarrollo de la enfermedad por VPH, ¿qué ocurre durante la etapa de latencia?

- A) El sistema inmunitario elimina completamente el genoma viral del organismo
- B) El virus permanece en los queratinocitos sin producir síntomas visibles
- C) El virus se replica masivamente destruyendo el estrato basal
- D) Las células infectadas se transforman inmediatamente en células cancerosas

24. Además del contacto sexual, ¿qué otra vía de transmisión directa es común para las verrugas cutáneas?

- A) Picadura de insectos
- B) Transmisión aérea (gotitas)
- C) Ingesta de alimentos contaminados
- D) Autoinoculación

25. ¿Por qué los papilomas laríngeos representan un riesgo de muerte en la población pediátrica?

- A) Posible obstrucción de las vías respiratorias
- B) Destrucción total de las cuerdas vocales por necrosis
- C) Inducción de fallo renal agudo
- D) Metástasis rápida hacia el cerebro

26. ¿Cuál es la efectividad reportada de los preservativos para reducir el riesgo de contagio del VPH?

- A) 30 al 60%
- B) 100%
- C) Menos del 5%
- D) 90 al 95%

27. ¿Qué característica morfológica define microscópicamente a una verruga?

- A) Hiperplasia de células espinosas e hiperqueratosis
- B) Atrofia del estrato basal con pérdida de melanina
- C) Destrucción de los capsómeros de los queratinocitos
- D) Infiltrado masivo de neutrófilos en la dermis papilar

28. ¿Cuál es el período de incubación (P.I.) típico para la aparición de verrugas comunes?

- A) 10 a 15 años
- B) 24 a 48 horas
- C) Hasta 3 o 4 meses
- D) Exactamente una semana

29. En la clasificación por localización, ¿cómo se agrupan los VPH?

- A) Aeróbicos o anaeróbicos
- B) Cutáneos o mucosos
- C) Agudos o fulminantes
- D) Sistémicos o localizados

30. ¿Qué tipos de cáncer son más frecuentes en hombres debido a la infección por VPH?

- A) Cáncer de próstata y vejiga
- B) Cáncer de pene, ano y orofaringe
- C) Cáncer de testículo
- D) Cáncer de pulmón y estómago

31. ¿Cuál es la principal razón por la que se recomienda extirpar las verrugas, a pesar de que pueden remitir espontáneamente?

- A) Para evitar el dolor, motivos estéticos y prevenir la autoinoculación
- B) Porque siempre se transforman en tumores malignos si no se quitan
- C) Para permitir que la vacuna funcione después de la cirugía
- D) Para eliminar el reservorio de ARN viral de la sangre

32. ¿Qué factor inmunológico explica que las verrugas desaparezcan por sí solas en muchos casos?

- A) La interferencia del virus JC que compite por la célula
- B) El agotamiento natural de los capsómeros virales
- C) La falta de queratina en el estrato espinoso
- D) La respuesta inmunitaria del hospedador

33. En el frotis de Papanicolaou, ¿qué significa el hallazgo de una Neoplasia Intraepitelial Cervical (CIN) de grado 2?

- A) Tejido completamente normal
- B) Displasia moderada
- C) Cáncer invasivo con metástasis
- D) Infección viral resuelta

4. Microbiología - Virología - Adenovirus

Virología · 31 preguntas · Fuente: Unidad 4.1 Adenovirus.pdf

1. La descripción estructural más correcta para adenovirus es:

- A) ARN negativo segmentado, con envoltura.
- B) ADN monocatenario circular, con envoltura.
- C) ARN bicatenario, cápside helicoidal.
- D) ADN bicatenario lineal, sin envoltura.
- E) ARN positivo, sin cápside.

2. Los principales antígenos de adenovirus se relacionan con:

- A) Hexonas, pentonas y fibras.
- B) HA, NA y proteína M2.
- C) E1, E2 y proteína NS1.
- D) Gp120, gp41 e integrasa.
- E) Esporozoito, merozoito y gametocito.

3. La replicación del ADN adenoviral ocurre principalmente en:

- A) Mitocondria.
- B) Citoplasma libre.
- C) Nucleo celular.
- D) Ribosoma bacteriano.
- E) Vacuola digestiva.

4. Una infección por adenovirus puede comprometer respiratorio, digestivo, urinario y ojo. Qué cuadro ocular es compatible?

- A) Catarata congénita.
- B) Uveítis toxoplásmica obligatoria.
- C) Retinopatía hipertensiva.
- D) Glaucoma agudo.
- E) Conjuntivitis.

5. Si se observan cuerpos de inclusión nuclear con acumulación de ADN y partículas defectuosas, el dato encaja con:

- A) Trypanosoma.
- B) Adenovirus.
- C) Strongyloides.
- D) Fasciola.
- E) Echinococcus.

6. A diferencia de varios virus envueltos, los adenovirus son relevantes en brotes porque:

- A) Mueren rápidamente fuera del hospedador.
- B) Solo infectan por vía sexual.
- C) No se liberan nunca por lisis.
- D) Tienen mayor resistencia ambiental al carecer de envoltura.
- E) No se transmiten entre humanos.

7. Qué afirmación sobre oncogenicidad es la más fiel al material?

- A) Todos causan cáncer cervical humano.
- B) Solo producen sarcoma de Kaposi.
- C) Algunos tipos son oncogénicos en animales, no así en humanos.
- D) Son oncogénicos solo por mosquitos.
- E) Transforman eritrocitos maduros.

8. La liberación del adenovirus desde la célula infectada se produce principalmente por:

- A) Lisis celular.
- B) Gemación apical permanente.
- C) Exocitosis de ooquistes.
- D) Salida por huevo embrionado.
- E) Fagocitosis inversa.

9. Una infección latente por adenovirus puede persistir en:

- A) Eritrocitos circulantes.
- B) Ganglios sensitivos exclusivamente.
- C) Macrófagos hepáticos obligados.
- D) Neumocitos sin núcleo.
- E) Células linfoides y adenoides.

10. En una epidemia de faringoconjuntivitis con piscina y conjuntivitis, ¿qué dato apoya adenovirus?

- A) Protozoo flagelado transmitido por vinchuca.
- B) Virus ADN sin envoltura resistente.
- C) Helminto con caracol intermediario.
- D) Virus ARN con transcriptasa inversa.
- E) Cestodo por pescado crudo.

11. ¿En qué tipo de cultivo celular se identificaron originalmente los adenovirus, lo que dio lugar a su nombre?

- A) Células de adenoides
- B) Linfocitos T CD4+
- C) Células epiteliales conjuntivales
- D) Enterocitos del intestino delgado

12. ¿Cuál es la configuración estructural característica del genoma de los adenovirus?

- A) ADN monocatenario lineal
- B) ADN bicatenario circular
- C) ARN monocatenario de sentido positivo
- D) ADN bicatenario lineal

13. ¿En qué compartimento celular tiene lugar la replicación del ADN vírico de los adenovirus?

- A) Citoplasma
- B) Ribosomas
- C) Retículo endoplásmico
- D) Núcleo

14. ¿Qué componentes estructurales constituyen los principales antígenos de los adenovirus?

- A) Polimerasa de ADN y helicasa
- B) Hexonas, pentonas y fibras
- C) Glucoproteínas de envoltura
- D) Proteína de matriz y nucleocápside

15. ¿Cuál es la causa histológica de la formación de cuerpos de inclusión nuclear en células infectadas por adenovirus?

- A) Fusión de membranas celulares para formar sincitios
- B) Aumento masivo del tamaño celular (citomegalia)
- C) Degradación del nucleolo por enzimas víricas
- D) Procesos de replicación y ensamblaje ineficaces

16. ¿Qué tipo de infección establecen los adenovirus en las células linfoides y adenoides?

- A) Infección lítica
- B) Infección latente
- C) Infección transformadora
- D) Infección persistente productiva

17. Respecto a la inmunidad contra los adenovirus, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) La inmunidad humoral es el único mecanismo para evitar la proliferación viral
- B) Los anticuerpos no confieren protección contra serotipos diferentes al de la infección original
- C) La infección previa garantiza inmunidad permanente contra todas las enfermedades respiratorias virales
- D) Existe protección cruzada universal entre los 52 serotipos humanos

18. ¿Qué característica de los adenovirus les permite transmitirse a través de piscinas con cloración inadecuada?

- A) Presencia de una envoltura lipídica protectora
- B) Termolabilidad extrema que favorece el contagio en agua templada
- C) Resistencia a la desecación, detergentes y cloro leve
- D) Capacidad de replicación en ambientes acuáticos salinos

19. ¿Cuáles son los serotipos de adenovirus más frecuentemente asociados con infecciones pediátricas de las vías respiratorias?

- A) Tipos 1, 2, 5 y 6
- B) Tipos 40 y 41
- C) Tipos 8, 19 y 37
- D) Tipos 4, 7 y 21

20. ¿Qué serotipos de adenovirus se propagan con mayor facilidad en entornos militares debido al hacinamiento y estilo de vida riguroso?

- A) Tipos 1 y 2
- B) Tipos 11 y 21
- C) Tipos 40 y 41
- D) Tipos 4 y 7

21. Un paciente presenta la tríada de faringitis, conjuntivitis y fiebre. ¿Qué cuadro clínico es el más probable?

- A) Síndrome de tipo tos ferina
- B) Fiebre faringoconjuntival
- C) Enfermedad respiratoria aguda
- D) Queratoconjuntivitis epidémica

22. ¿Cuál es la principal diferencia clínica entre la conjuntivitis y la queratoconjuntivitis por adenovirus?

- A) La presencia de fiebre en la conjuntivitis
- B) La edad del paciente, afectando la queratoconjuntivitis solo a lactantes
- C) La vía de transmisión, que es solo fecal-oral en la conjuntivitis
- D) La presencia de dolor en la queratoconjuntivitis

23. ¿Qué serotipos de adenovirus se clasifican en el grupo F y son responsables de diarrea en lactantes?

- A) Serotipos 3, 4 y 7
- B) Serotipos 40 y 41
- C) Serotipos 11 y 21
- D) Serotipos 1, 2 y 5

24. ¿Cuál de las siguientes es una manifestación clínica de los adenovirus en el aparato urinario?

- A) Insuficiencia renal aguda obstructiva
- B) Cistitis hemorrágica aguda
- C) Sepsis urinaria por Gram negativos
- D) Glomerulonefritis post-infecciosa

25. ¿Cómo se realiza el diagnóstico definitivo de la infección por adenovirus en el laboratorio?

- A) Cultivo en agar sangre y chocolate
- B) PCR y análisis de sondas de ADN
- C) Observación macroscópica de las secreciones
- D) Prueba de la tuberculina (PPD)

26. En cuanto al tratamiento de las infecciones por adenovirus, ¿cuál es la recomendación actual?

- A) No existe un tratamiento específico aprobado
- B) Uso de antibióticos de amplio espectro de forma profiláctica
- C) Terapia de reemplazo enzimático nuclear
- D) Administración inmediata de aciclovir oral

27. ¿Qué medida de prevención es fundamental para controlar la propagación de adenovirus en instalaciones recreativas?

- A) Cloración adecuada de las piscinas
- B) Vacunación universal de la población civil
- C) Uso de mascarillas N95 en todas las áreas
- D) Hervir el agua de las piscinas antes de cada uso

28. ¿Para qué población está disponible la vacuna oral contra los tipos 4 y 7 de adenovirus?

- A) Adultos mayores inmunodeprimidos
- B) Personal militar
- C) Lactantes y niños pequeños
- D) Pacientes con cáncer de colon

29. ¿Cuál es un uso terapéutico moderno de los adenovirus mencionado en el material?

- A) Desinfección de superficies hospitalarias
- B) Tratamiento antibiótico para la tuberculosis
- C) Vectores para vacunas contra el Ebola y Covid-19
- D) Producción de insulina recombinante en el páncreas

30. ¿En qué momento se inicia la transcripción genética tardía durante el ciclo de replicación de los adenovirus?

- A) Antes de que se sintetice la polimerasa de ADN
- B) Inmediatamente después de la entrada del virus a la célula
- C) Cuando ha finalizado la replicación del ADN
- D) Simultáneamente con la lisis celular

31. ¿Cómo se liberan los viriones de adenovirus de la célula infectada?

- A) Exocitosis mediante vesículas de transporte
- B) Paso directo a través de poros nucleares
- C) Lisis celular
- D) Gemación a través de la membrana plasmática

5. Microbiología - Virología - Parvovirus y Poxvirus

Virología · 38 preguntas · Fuente: Unidad 4.2 PARVOVIRUS Y POXVIRUS.pdf

1. Parvovirus B19 se distingue estructuralmente porque es:

- A) ADN monocatenario lineal, pequeño y sin envoltura.
- B) ARN segmentado negativo, envuelto.
- C) ADN bicatenario gigante, envuelto.
- D) ARN positivo helicoidal, sin cápside.
- E) ADN circular con transcriptasa inversa.

2. El tropismo central del parvovirus B19 explica que destruya principalmente:

- A) Neurona de ganglio dorsal.
- B) Hepatocito adulto.
- C) Células precursoras eritroides.
- D) Queratinocito cornificado.
- E) Enterocito ciliado.

3. Un paciente con anemia hemolítica crónica desarrolla aplasia transitoria intensa. Qué virus debe considerarse?

- A) Adenovirus ocular.
- B) Virus rubéola.
- C) VHH-8.
- D) Rinovirus.
- E) Parvovirus B19.

4. En la evolución bifásica por B19, el exantema y la artralgia suelen ser:

- A) Fase de máxima contagiosidad respiratoria.
- B) Mediados por respuesta inmunitaria.
- C) Debidos a larvas pulmonares.
- D) Secuela de infección por poxvirus.
- E) Resultado de huevos en bilis.

5. Durante la primera fase de B19, la contagiosidad se relaciona con:

- A) Quistes en heces formadas.
- B) Metacercarias en vegetales.
- C) Mordedura de murciélago.
- D) Viremia y secreciones respiratorias.
- E) Proglotides en heces.

6. En embarazada, B19 preocupa porque puede provocar:

- A) Condiloma acuminado fetal.
- B) Hidrofobia neonatal.
- C) Hidropesía fetal por anemia.
- D) Megacolon congénito.
- E) Quiste hidatídico pulmonar.

7. Una diferencia importante de poxvirus frente a muchos virus ADN es que:

- A) Replica en el citoplasma.
- B) No posee ningún genoma.
- C) Necesita eritrocitos maduros.
- D) Es siempre no envuelto.
- E) Solo se transmite por alimentos.

8. Los poxvirus se reconocen como virus:

- A) Pequeños, desnudos y de ARN positivo.
- B) Helicoidales en forma de bala.
- C) Segmentados con neuraminidasa.
- D) Flagelados con cinetoplasto.
- E) Grandes, complejos y de ADN bicatenario.

9. La vacuna histórica que permitió controlar la viruela se relaciona con:

- A) Rotavirus.
- B) Vaccinia.
- C) VEB.
- D) Toxoplasma.
- E) Schistosoma.

10. Molluscum contagiosum se debe ubicar dentro del grupo de:

- A) Parvovirus.
- B) Flavivirus.
- C) Cestodos.
- D) Poxvirus.
- E) Trematodos.

11. ¿Cuál es la característica estructural distintiva que define a los parvovirus dentro de los virus de ADN?

- A) Su replicación es exclusivamente citoplasmática.
- B) Presentan una cápside icosaédrica con envoltura lipídica.
- C) Poseen un genoma de ADN bicatenario circular.
- D) Son los virus de ADN de menor tamaño y poseen ADN monocatenario lineal.

12. Durante el ciclo de replicación del parvovirus B19, ¿qué paso es indispensable para que ocurra la transcripción y replicación del genoma vírico?

- A) La integración del genoma vírico en el ADN celular.
- B) La formación de un intermediario de ARN de polaridad negativa.
- C) La salida del núcleo hacia el citoplasma para el ensamblaje del virión.
- D) La síntesis de una cadena complementaria para formar ADN bicatenario.

13. En la evolución bifásica de la infección por B19, ¿cuál es el evento fisiopatológico central de la primera fase (fase febril)?

- A) La aparición del exantema en 'mejilla abofeteada' por inmunocomplejos.
- B) El desarrollo de poliartritis crónica en pacientes pediátricos.
- C) La producción masiva de anticuerpos IgG específicos.
- D) Una intensa viremia y la destrucción lítica de precursores eritroides.

14. ¿Por qué un paciente con eritema infeccioso (quinta enfermedad) ya no se considera contagioso al momento de aparecer el exantema?

- A) Porque el exantema es una manifestación inmunológica posterior a la viremia.
- B) Porque el descenso de la hemoglobina impide la replicación viral.
- C) Porque el virus ha mutado a una forma no patógena.
- D) Porque el virus solo se transmite a través de las costras del exantema.

15. En adultos infectados por parvovirus B19, ¿cuál es la manifestación clínica que predomina sobre el exantema cutáneo?

- A) Crisis aplásica aguda de forma universal.
- B) Bronquiolitis grave y dificultad respiratoria.
- C) Formación de nódulos umbilicados en los genitales.
- D) Poliartritis y artralgias que pueden durar semanas o meses.

16. ¿Cuál es la complicación más grave de la infección por parvovirus B19 en pacientes con anemia hemolítica crónica?

- A) Desarrollo de malformaciones congénitas cardíacas.
- B) Crisis aplásica debida al agotamiento de precursores eritrocitarios.
- C) Insuficiencia hepática fulminante por viremia secundaria.
- D) Eritema infeccioso recidivante.

17. ¿Qué riesgo enfrentan las mujeres embarazadas seronegativas ante una infección por parvovirus B19?

- A) Ninguno, ya que el virus no atraviesa la placenta.
- B) Desarrollo inmediato de molusco contagioso gestacional.
- C) Riesgo de muerte fetal por anemia e insuficiencia cardíaca (hidropesía fetal).
- D) Transmisión de inmunidad pasiva al feto sin riesgos asociados.

18. ¿Cuál es la principal diferencia epidemiológica entre el parvovirus B19 y el bocavirus?

- A) El B19 afecta a animales domésticos y el bocavirus solo a humanos.
- B) El B19 tiene vacuna disponible y el bocavirus no.
- C) El bocavirus se asocia con enfermedades respiratorias y se transmite también por las heces.
- D) El B19 es un virus de ARN y el bocavirus es de ADN.

19. Respecto a los poxvirus, ¿cuál es el sitio celular donde completan su ciclo de replicación, a diferencia de la mayoría de los virus de ADN?

- A) En el citoplasma.
- B) En la membrana plasmática.
- C) En el nucleolo celular.
- D) En las mitocondrias.

20. En la patogenia de la viruela humana, ¿qué evento sigue a la viremia secundaria?

- A) La desaparición inmediata de los síntomas sistémicos.
- B) La erupción de pústulas características en la piel y mucosas.
- C) La inmunización automática contra el parvovirus B19.
- D) La formación de inclusiones citoplasmáticas denominadas cuerpos de Molluscum.

21. ¿Cuál es el reservorio natural de la viruela del mono (Mpx) y cómo se clasifica su transmisión al ser humano?

- A) Es un producto de laboratorio usado para vacunas.
- B) Su reservorio son las aves migratorias y es una infección vectorial.
- C) Se encuentra en animales (monos, ardillas) y es una zoonosis.
- D) Es un virus exclusivo de humanos transmitido por el aire.

22. ¿Cuál es la morfología característica de las lesiones producidas por el virus del Molusco Contagioso?

- A) Exantema maculopapular difuso en 'encaje'.
- B) Vesículas transparentes que siguen el trayecto de un nervio.
- C) Pústulas hemorrágicas que dejan cicatrices profundas.
- D) Nódulos umbilicados con un tapón caseoso central.

23. En el diagnóstico de laboratorio del molusco contagioso, ¿qué hallazgo histopatológico es determinante?

- A) Presencia de grandes inclusiones citoplásmicas eosinófilas (cuerpos de Molluscum).
- B) Presencia de anticuerpos IgM contra el antígeno eritrocitario P.
- C) Aislamiento de linfocitos CD4 bajos en sangre periférica.
- D) Detección de ADN monocatenario mediante PCR.

24. ¿Cómo se transmiten comúnmente las zoonosis por poxvirus como el Orf y la viruela bovina?

- A) Por contacto directo con lesiones de animales infectados (ovejas, vacas).
- B) Por la picadura de garrapatas infectadas.
- C) A través del consumo de leche no pasteurizada.
- D) Por inhalación de polvo contaminado en establos.

25. Un niño de 18 meses presenta bronquiolitis y síntomas de infección respiratoria grave. Se detecta un parvovirus en sus secreciones. ¿Cuál es el agente más probable?

- A) Virus del Molusco Contagioso.
- B) Virus Orf.
- C) Bocavirus.
- D) Parvovirus B19.

26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la prevención del parvovirus humano es correcta según el material?

- A) La vacunación sistemática en la infancia es el método principal.
- B) El lavado de manos y el uso de tapabocas ayudan a prevenir la diseminación.
- C) El uso de preservativos garantiza la eliminación del riesgo de contagio de B19.
- D) Las vacunas para perros y gatos protegen también a los humanos.

27. ¿Qué factor puede exacerbar o provocar la recurrencia del exantema en la quinta enfermedad durante varias semanas?

- A) El tratamiento con antibióticos de amplio espectro.
- B) La exposición a la luz solar, calor o ejercicio físico.
- C) El consumo de alimentos ácidos.
- D) La reinfección inmediata por el mismo serotipo del virus.

28. En el contexto de la viruela del mono (Mpx), ¿cuándo se considera que una persona deja de ser infecciosa?

- A) A los 5 días de iniciado el tratamiento con Cidofovir.
- B) Inmediatamente después de recibir la vacuna post-exposición.
- C) Cuando las lesiones se han cubierto de costras, estas han caído y hay piel nueva debajo.
- D) En cuanto desaparece la fiebre inicial.

29. ¿Cuál es la causa del exantema y la artralgia en la segunda fase de la infección por parvovirus B19?

- A) La toxicidad sistémica por la liberación de hemoglobina fetal.
- B) La respuesta inmunitaria y el depósito de complejos antígeno-anticuerpo.
- C) Una sobreinfección bacteriana oportunista en la piel.
- D) La replicación viral directa en los sinoviocitos y queratinocitos.

30. De acuerdo con la clasificación de los poxvirus, ¿cuál de ellos se asocia con el 'Nódulo del Milker'?

- A) Virus Vaccinia.
- B) Virus de la estomatitis papulosa bovina.
- C) Seudoviruela bovina.
- D) Viruela de Tana.

31. En el caso clínico presentado, ¿por qué la madre presentaba cansancio y dolor articular mientras la hija solo tenía el exantema facial?

- A) Porque la madre padecía una enfermedad autoinmune no relacionada.
- B) Porque el B19 produce síntomas diferentes según la edad (artritis en adultos vs exantema en niños).
- C) Porque el virus B19 muta al pasar de niño a adulto.
- D) Porque la madre estaba en la fase infecciosa y la hija en la fase prodrómica.

32. ¿Qué característica genómica comparten los virus de las familias Parvoviridae y Poxviridae según el material?

- A) Ambos son virus con genoma de ADN monocatenario.
- B) Ambos son virus cuyo material genético principal es el ADN.
- C) Ambos requieren una enzima retrotranscriptasa para replicarse.
- D) Ambos poseen genomas de ADN de gran tamaño.

33. ¿Cómo se pueden eliminar físicamente los nódulos del molusco contagioso para acelerar la curación?

- A) Raspado (curetaje), nitrógeno líquido o soluciones de yodo.
- B) Mediante la aplicación de ungüentos antibióticos potentes.
- C) Aspiración con aguja fina del contenido caseoso.
- D) Exposición prolongada a la luz ultravioleta.

34. ¿Cuál es la tasa de mortalidad aproximada asociada a la Viruela Mayor?

- A) Entre el 15% y el 40%.
- B) Exactamente el 50% debido a la respuesta inmunitaria.
- C) Menos del 1%.
- D) Casi del 100% en todos los casos.

35. ¿Qué síntoma inicial e inespecífico caracteriza el 'periodo prodrómico' del parvovirus B19?

- A) Anemia hemolítica súbita en pacientes sanos.
- B) Fiebre, escalofríos, malestar y mialgias.
- C) Descamación severa de las palmas de las manos.
- D) Cefalea intensa y lumbalgia de tipo pustuloso.

36. ¿En qué región anatómica suele aparecer primero el exantema de la viruela antes de extenderse al resto del cuerpo?

- A) En el área genital únicamente.
- B) Exclusivamente en las mejillas.
- C) En las plantas de los pies.
- D) En la cavidad bucal.

37. En pacientes inmunodeprimidos, ¿qué curso suele tomar la infección por parvovirus B19?

- A) Transformación maligna de los precursores eritroides (leucemia).
- B) Infección latente en las neuronas sensitivas.
- C) Resolución acelerada por hiperactividad inmune.
- D) Enfermedad crónica por incapacidad de aclarar la viremia.

38. ¿Qué característica del genoma de los parvovirus hace que su replicación sea dependiente de la fase S del ciclo celular de la célula huésped?

- A) Su gran tamaño requiere mucha energía mitocondrial.
- B) La necesidad de polimerasas de ADN celulares que solo se expresan durante la división.
- C) La presencia de una envoltura que se disuelve con el huso mitótico.
- D) Su capacidad para inducir apoptosis en células en reposo.

6. Microbiología - Virología - Picornavirus

Virología · 10 preguntas · Fuente: Unidad 5 Picornavirus.pdf

1. La descripción más correcta de los picornavirus es:

- A) ARN negativo segmentado, cápside helicoidal y envoltura.
- B) ADN bicatenario lineal, fibras y pentonas.
- C) ARN positivo monocatenario, cápside icosaédrica y sin envoltura.
- D) ADN monocatenario, eritrotropo y envuelto.
- E) ARN bicatenario con transcriptasa inversa.

2. Los enterovirus, aunque se transmiten por vía fecal-oral, normalmente:

- A) Se destruyen siempre en el estómago.
- B) Requieren picadura de mosquito.
- C) Solo infectan el ojo.
- D) Tienen envoltura muy frágil.
- E) No provocan enfermedades entéricas como rasgo principal.

3. Qué propiedad favorece la transmisión fecal-oral de enterovirus?

- A) Labilidad extrema a pH neutro.
- B) Resistencia a ácido gástrico, bilis y detergentes.
- C) Necesidad de vector biológico.
- D) Latencia en ganglios sensitivos.
- E) Replicación solo nuclear.

4. Los rinovirus se diferencian de los enterovirus porque:

- A) Son virus ADN envueltos.
- B) Se transmiten por heces de felinos.
- C) Producen huevos en vías biliares.
- D) Son lábiles a pH ácido y crecen mejor a 33 °C.
- E) Tienen fase de trofozoito.

5. El poliovirus puede producir parálisis porque afecta principalmente:

- A) Linfocitos B de amígdala.
- B) Células precursoras eritroides.
- C) Neuronas motoras del asta anterior.
- D) Conductos biliares intrahepáticos.
- E) Queratinocitos del estrato córneo.

6. Coxsackie A se vincula clásicamente con:

- A) Herpangina y mano-pie-boca.
- B) Rabia parálisis.
- C) Sarcoma de Kaposi.
- D) Fasciolosis hepática.
- E) Neurocisticercosis.

7. Coxsackie B debe recordarse por su relación con:

- A) Verrugas plantares.
- B) Hidatidosis pulmonar.
- C) Paludismo terciario.
- D) Leishmaniasis visceral.
- E) Miocarditis y pleurodinia.

8. En picornavirus, la replicación ocurre principalmente en:

- A) Nucleo con inclusión grande.
- B) Citoplasma de la célula.
- C) Mitocondria exclusivamente.
- D) Eritrocito sin núcleo.
- E) Intestino del mosquito.

9. Un cuadro de meningitis aseptica en verano por virus pequeño ARN positivo puede relacionarse con:

- A) Poxvirus.
- B) Toxoplasma.
- C) Fasciola.
- D) Enterovirus.
- E) Bothrops.

10. La prevención de poliomiелitis se basa principalmente en:

- A) Vacunación.
- B) Suero antiofídico.
- C) Antibiótico betalactámico.
- D) Desparasitación canina única.
- E) Cocción de pescado.

7. Microbiología - Virología - Orthomixovirus y Reovirus

Virología · 10 preguntas · Fuente: Unidad 6 Orthomixovirus y Reovirus.pdf

1. La estructura de influenza A y B incluye:

- A) ADN circular sin envoltura.
- B) Un solo ADN monocatenario.
- C) ARN positivo no segmentado.
- D) Capsidom desnuda con espículas ausentes.
- E) Ocho segmentos de ARN y envoltura.

2. El cambio antigénico menor por mutación en influenza A y B se denomina:

- A) Salto antigénico.
- B) Deriva antigénica.
- C) Latencia ganglionar.
- D) Existencia.
- E) Autoinfección.

3. El cambio mayor por reorganización de segmentos ocurre sobre todo en:

- A) Influenza C.
- B) Rinovirus.
- C) Parvovirus B19.
- D) Influenza A.
- E) VHH-6.

4. Qué glicoproteínas son los antígenos principales de influenza?

- A) Gp120 y gp41.
- B) E1 y E2 del HPV.
- C) Hemaglutinina y neuraminidasa.
- D) Hexona y pentona.
- E) VP1 y VP2 de parvovirus.

5. La neuraminidasa facilita principalmente:

- A) Liberación de nuevos viriones.
- B) Entrada por retrotranscripción.
- C) Conversión de quiste a trofozoito.
- D) Penetración larvaria cutánea.
- E) Producción de huevos operculados.

6. El genoma segmentado de influenza facilita pandemias porque permite:

- A) Fijación irreversible de un solo subtipo.
- B) Ausencia de variabilidad genética.
- C) Transformación en bacteria.
- D) Multiplicación sin células.
- E) Reorganización entre cepas humanas y animales.

7. Un diagnóstico molecular temprano de influenza se apoya mejor en:

- A) Cinta adhesiva perianal.
- B) RT-PCR de muestra respiratoria.
- C) Gota gruesa hepática.
- D) Biopsia de piel para huevos.
- E) Hemocultivo micológico.

8. Los reovirus/rotavirus se caracterizan por:

- A) ADN monocatenario envuelto.
- B) ARN negativo con forma de bala.
- C) Protozoo flagelado con quiste.
- D) ARN bicatenario segmentado y cápside resistente.
- E) Cestodo de varios metros.

9. Rotavirus produce diarrea especialmente por:

- A) Infeccion intestinal con perdida de absorcion y secrecion.
- B) Invasion de vías biliares por adultos.
- C) Necrosis de neuronas del asta anterior.
- D) Quistes tisulares en musculo.
- E) Toxina de veneno crotalico.

10. La prevencion especifica más importante frente a rotavirus grave en lactantes es:

- A) Antiveneno equino.
- B) Vacuna HPV.
- C) Vacunacion oral.
- D) Coccion de pescado.
- E) Uso de preservativo exclusivo.

8. Microbiología - Virología - Paramixovirus

Virología · 10 preguntas · Fuente: Unidad 7 Paramixovirus.pdf

1. La estructura general de Paramixovirus corresponde a:

- A) ADN lineal desnudo con fibras.
- B) ARN negativo, núcleocapside helicoidal y envoltura.
- C) ARN positivo desnudo pequeño.
- D) ADN monocatenario eritrotropo.
- E) ARN bicatenario de cápside triple.

2. Un ECP típico de paramixovirus es la formación de:

- A) Huevos con mamelones regulares.
- B) Cuerpos de inclusión nuclear exclusivos.
- C) Larvas filariformes en piel.
- D) Células gigantes multinucleadas por fusión.
- E) Quistes hidatídicos.

3. El virus del sarampión se recuerda porque:

- A) Tiene reservorio principal en gatos.
- B) Se transmite por pescado crudo.
- C) Tiene un solo tipo y el humano es su único hospedero.
- D) Requiere caracol Lymnaea.
- E) Es un cestodo intestinal.

4. ¿Qué dato clínico orienta a sarampión clásico?

- A) Exantema con prodromo respiratorio y manchas de Koplik.
- B) Hidrofobia luego de mordedura.
- C) Úlceras genitales recurrentes.
- D) Diarrea grasa sin fiebre.
- E) Dolor en hipocondrio con huevos biliares.

5. Parainfluenza es importante en pediatría por su relación con:

- A) Sarcoma de Kaposi.
- B) Anemia megaloblástica.
- C) Cisticercosis.
- D) Fasciolosis.
- E) Crup o laringotraqueobronquitis.

6. El virus de la parotiditis se asocia de forma clásica con:

- A) Verrugas plantares y condilomas.
- B) Parotiditis, orquitis y meningitis aseptica.
- C) Bronquiolitis por sincitios en lactantes.
- D) Hidatidosis hepática.
- E) Anemia por B12.

7. El virus respiratorio sincitial causa mayor preocupación en:

- A) Adultos con quiste biliar.
- B) Pescadores con anemia B12.
- C) Pacientes con mordedura de serpiente.
- D) Lactantes con bronquiolitis.
- E) Embarazadas con HPV cutáneo.

8. La proteína F de varios paramixovirus se relaciona con:

- A) Fusión de membranas y sincitios.
- B) Retrotranscripción del ARN.
- C) Liberación por neuraminidasa.
- D) Formación de oocistos.
- E) Penetración de cercarias.

9. La vacuna de sarampión se administra dentro de:

- A) Vacuna antirrábica posexposición.
- B) Vacuna antirotavirus oral.
- C) Triple viral o SRP/MMR.
- D) Vacuna antihepatitis B exclusiva.
- E) Antiveneno polivalente.

10. Metapneumovirus humano se considera dentro del abordaje de:

- A) Teniasis por carne de cerdo.
- B) Protozoarios urogenitales.
- C) Accidentes ofídicos.
- D) Trematodos hepáticos.
- E) Infecciones respiratorias, sobre todo en niños.

9. Microbiología - Virología - Rhabdovirus

Virología · 10 preguntas · Fuente: Unidad 8 Rhabdovirus.pdf

1. La morfología clásica del virus de la rabia es:

- A) Capsídem icosaédrica desnuda pequeña.
- B) Bacilo grampositivo esporulado.
- C) Huevo operculado grande.
- D) Virión envuelto en forma de bala.
- E) Gusano plano segmentado.

2. El genoma del virus rabico es:

- A) ADN circular bicatenario.
- B) ARN positivo segmentado.
- C) ARN monocatenario negativo.
- D) ADN monocatenario lineal.
- E) ARN bicatenario con cápside triple.

3. Una exposicion humana típica a rabia ocurre por:

- A) Mordedura o lamida de animal infectado sobre mucosa/herida.
- B) Ingestion de pescado crudo.
- C) Picadura de Anopheles hembra.
- D) Contacto con heces de gato con ooquistes.
- E) Consumo de berro con metacercarias.

4. Qué factor acorta o agrava el periodo de incubacion de rabia?

- A) Lesion lejana en pie sin inculo.
- B) Vacunacion previa completa.
- C) Baja concentracion viral.
- D) Piel intacta sin contacto.
- E) Herida cercana al cerebro.

5. Despues de replicarse en el sitio de inoculacion, el virus rabico progresa hacia el SNC por:

- A) Huevos en vía biliar.
- B) Transporte neural retrogrado.
- C) Fecalismo intestinal.
- D) Viremia masiva por eritrocitos.
- E) Larvas por circulacion portal.

6. El tiempo de observacion del perro o gato agresor se relaciona con el periodo de transmisibilidad y suele ser:

- A) 24 horas.
- B) 3 meses.
- C) 2 años.
- D) 10 días.
- E) 18 días.

7. El cuadro neurologico clasico de rabia puede incluir:

- A) Hidrofobia, agitacion, encefalitis y coma.
- B) Diarrea grasa crónica.
- C) Exantema en mejilla abofeteada.
- D) Condilomas genitales.
- E) Anemia megaloblastica por pescado.

8. La conducta inicial más correcta ante mordedura sospechosa es:

- A) Cerrar la herida sin limpieza.
- B) Aplicar torniquete por 24 horas.
- C) Lavado inmediato, evaluación y profilaxis según riesgo.
- D) Esperar fiebre antes de actuar.
- E) Dar solo analgésico y alta.

9. El diagnóstico postmortem clásico de rabia puede apoyarse en:

- A) Huevos mamelonados en heces.
- B) Quistes de Giardia en duodeno.
- C) Proglótides gravidas.
- D) Amastigotes en sangre periférica.
- E) Cuerpos de Negri o inmunofluorescencia en tejido nervioso.

10. Filovirus, incluidos Ebola y Marburg, se diferencian por ser:

- A) ADN pequeños desnudos eritrotropos.
- B) ARN negativos envueltos filamentosos con fiebre hemorrágica.
- C) Protozoos con flebotomo vector.
- D) Cestodos por carne bovina.
- E) Trematodos con caracol Lymnaea.

10. Microbiología - Virología - Togavirus y Flavivirus

Virología · 10 preguntas · Fuente: Unidad 9 Togavirus y Flavivirus.pdf

1. Alfavirus y flavivirus comparten como rasgo estructural:

- A) ADN bicatenario sin envoltura.
- B) ARN negativo en forma de bala.
- C) ARN monocatenario positivo con envoltura.
- D) ADN monocatenario eritrotropo.
- E) Genoma circular con transcriptasa inversa.

2. La replicación de alfavirus ocurre principalmente en:

- A) Citoplasma.
- B) Nucleo.
- C) Eritrocito maduro.
- D) Conducto biliar.
- E) Ganglio sensorial.

3. En arbovirus, el término vector biológico se aplica con mayor frecuencia a:

- A) Caracol Lymnaea.
- B) Perro doméstico.
- C) Pescado de agua dulce.
- D) Gato definitivo.
- E) Mosquito hembra hematofago.

4. Dengue grave tras una segunda infección por serotipo distinto se explica mejor por:

- A) Latencia en ganglios dorsales.
- B) Potenciación dependiente de anticuerpos.
- C) Autoinfección intestinal.
- D) Toxina neurotrópica salival.
- E) Destrucción de vitamina B12.

5. En dengue temprano, una combinación diagnóstica útil es:

- A) Cinta adhesiva y coproparasitológico.
- B) Gota gruesa para larvas.
- C) Cultivo de bilis para huevos.
- D) NS1 o RT-PCR, luego IgM/IgG según días.
- E) Biopsia de músculo para quistes.

6. Chikungunya se reconoce clínicamente por:

- A) Fiebre con artralgias intensas y persistentes.
- B) Hidrofobia y espasmos faríngeos.
- C) Diarrea grasa por mala absorción.
- D) Parálisis flácida por asta anterior.
- E) Hematuria por huevos vesicales.

7. Zika tiene especial importancia en gestación por su relación con:

- A) Eritema infeccioso por B19.
- B) Sarcoma de Kaposi neonatal.
- C) Síndrome congénito y microcefalia.
- D) Hidatidosis pulmonar fetal.
- E) Aplasia medular por HPV.

8. La fiebre amarilla se previene de forma específica con:

- A) Vacuna antirrábica únicamente.
- B) Antibiótico macrolido.
- C) Antihelmíntico para perros.
- D) Cocci de pescado.
- E) Vacuna viva atenuada y control vectorial.

9. El virus de la rubéola pertenece al género:

- A) Flavivirus.
- B) Rubivirus.
- C) Lentivirus.
- D) Enterovirus.
- E) Rhabdovirus.

10. La rubéola congénita se previene principalmente mediante:

- A) Tratamiento con antiveneno.
- B) Hervir pescado de río.
- C) Desecación de quistes.
- D) Vacunación previa a embarazo y control de susceptibles.
- E) Observación de animales 10 días.

11. Microbiología - Virología - Retrovirus

Virología · 10 preguntas · Fuente: UNIDAD 10 Retrovirus.pdf

1. La característica que define a los retrovirus es la presencia de:

- A) Transcriptasa inversa.
- B) Neuraminidasa.
- C) Hemaglutinina.
- D) Cuerpo de Negri.
- E) Disco succionario.

2. El genoma de VIH se describe mejor como:

- A) ADN bicatenario lineal sin envoltura.
- B) ARN negativo segmentado.
- C) ADN monocatenario sin envoltura.
- D) ARN bicatenario de cápside triple.
- E) ARN monocatenario positivo con envoltura.

3. La integrasa del VIH permite:

- A) Unir virus a ácido siálico.
- B) Incorporar el ADN proviral al genoma celular.
- C) Liberar viriones por neuraminidasa.
- D) Formar quistes resistentes.
- E) Producir huevos embrionados.

4. Las células diana principales del VIH expresan:

- A) Antígeno P eritrocitario.
- B) Receptor de bilis.
- C) Quitina externa.
- D) CD4 y correceptores como CCR5/CXCR4.
- E) Botrios del escolelex.

5. La disminución progresiva de CD4 explica principalmente:

- A) Inmunodeficiencia celular y infecciones oportunistas.
- B) Anemia por consumo de B12.
- C) Obstrucción intestinal por adultos.
- D) Fiebre por esquizogonía eritrocitaria.
- E) Dermatitis por pediculosis.

6. Una prueba inicial moderna de tamizaje de VIH suele detectar:

- A) Huevos en heces seriadas.
- B) Trofozoitos móviles en fresco.
- C) Antígeno p24 y anticuerpos anti-VIH.
- D) Cercarias en agua.
- E) Veneno en sangre.

7. La carga viral por PCR se usa principalmente para:

- A) Identificar huevos operculados.
- B) Clasificar mordeduras ofídicas.
- C) Medir vitamina B12 por cestodos.
- D) Detectar larvas en cinta adhesiva.
- E) Monitorear replicación y respuesta al tratamiento.

8. La terapia antirretroviral combinada busca:

- A) Eliminar solo bacterias anaerobias.
- B) Bloquear distintas etapas de la replicación viral.
- C) Neutralizar venenos de serpientes.
- D) Paralizar nematodos intestinales únicamente.
- E) Destruir ooquistes ambientales.

9. HTLV-1 se asocia especialmente con:

- A) Condiloma acuminado.
- B) Rabia paralítica.
- C) Fasciolosis biliar.
- D) Leucemia/linfoma de células T del adulto.
- E) Cisticercosis muscular.

10. Una medida preventiva esencial para VIH es:

- A) Evitar exclusivamente gatos.
- B) Cocinar vegetales acuáticos.
- C) Uso de preservativo, sangre segura y control prenatal.
- D) Observar perros por 10 días.
- E) No caminar descalzo.

12. Microbiología - Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención

Parasitología · 10 preguntas · Fuente: 1 Parasitología Generalidades.pptx.pdf

1. En parasitología, el huésped definitivo se define mejor como aquel en el que el parásito:

- A) Permanece siempre como quiste ambiental.
- B) Solo se transporta mecánicamente sin cambiar.
- C) Muere antes de completar el ciclo.
- D) No produce ningún dano.
- E) Realiza reproducción sexual o alcanza madurez adulta.

2. El huésped intermediario se reconoce porque en él ocurre:

- A) Únicamente diagnóstico serológico.
- B) Desarrollo larvario o reproducción asexual.
- C) La eliminación obligatoria de anticuerpos.
- D) El tratamiento farmacológico.
- E) La vacunación del humano.

3. Un reservorio epidemiológico es importante porque:

- A) Siempre elimina el parásito por tos.
- B) Impide toda zoonosis.
- C) Es sinónimo de vector mecánico.
- D) Mantiene el parásito disponible para transmisión.
- E) Solo existe en virus envueltos.

4. La diferencia más adecuada entre vector biológico y mecánico es:

- A) En el biológico el agente se desarrolla o multiplica; en el mecánico solo se transporta.
- B) El biológico nunca transmite enfermedad.
- C) El mecánico siempre inyecta saliva infectante.
- D) Ambos requieren reproducción sexual del parásito.
- E) Solo el mecánico tiene importancia médica.

5. La prevención comunitaria de parasitosis intestinales se centra sobre todo en:

- A) Aislamiento respiratorio estricto permanente.
- B) Antivirales de amplio espectro.
- C) Agua segura, saneamiento, higiene y alimentos limpios.
- D) Vacuna antitetánica como única medida.
- E) Cierre de escuelas sin educación sanitaria.

6. Una parasitosis zoonótica implica que:

- A) Solo existe en cultivos celulares.
- B) No requiere ningún huésped.
- C) Siempre se transmite por transfusión.
- D) Nunca involucra reservorios.
- E) Puede transmitirse entre animales vertebrados y humanos.

7. Para parásitos intestinales con eliminación intermitente de formas diagnósticas, ¿qué estrategia mejora el rendimiento?

- A) Radiografía simple única.
- B) Examen coproparasitológico seriado.
- C) Hemocultivo para anaerobios.
- D) Prueba de catalasa.
- E) Tinción de Gram de piel.

8. Los protozoarios se diferencian de los helmintos porque generalmente son:

- A) Pluricélulares segmentados.
- B) Artrópodos con exoesqueleto.
- C) Serpientes venenosas.
- D) Unicélulares.
- E) Hongos filamentosos.

9. Una medida de APS contra parásitosis transmitidas por suelo debe priorizar:

- A) Solo antitermicos.
- B) Vacuna SRP.
- C) Letrinas, calzado y lavado de manos.
- D) Antiveneno preventivo.
- E) Uso de lentes de sol.

10. Si un parásito necesita más de un huésped para completar su ciclo, se trata de un ciclo:

- A) Indirecto o heteroxeno.
- B) Directo o monoxeno.
- C) Aviral.
- D) Saprofito estricto.
- E) Exclusivamente mecanico.

13. Microbiología - Parasitología - Paludismo

Parasitología · 10 preguntas · Fuente: 2 Unidad XVI.1 Paludismo.pdf

1. La definición más completa de paludismo incluye infección por Plasmodium y transmisión habitual por:

- A) Triatominos hematofagos.
- B) Hembras de Anopheles.
- C) Flebotomos.
- D) Caracoles Lymnaea.
- E) Pulgas de perro.

2. El primer sitio de multiplicación del Plasmodium después de la inoculación vectorial es:

- A) Vejiga.
- B) Ganglio sensorial.
- C) Intestino grueso.
- D) Hígado.
- E) Vía biliar.

3. Los paroxismos febriles se relacionan principalmente con:

- A) Ruptura sincrónica de eritrocitos parasitados.
- B) Migración de larvas por pulmón.
- C) Liberación de huevos por proglótides.
- D) Invasión de queratinocitos.
- E) Mordedura local de serpiente.

4. P. falciparum es especialmente temido porque puede producir:

- A) Solo infección leve sin complicaciones.
- B) Quistes hepáticos calcificados.
- C) Paludismo grave y muerte rápida sin tratamiento.
- D) Verrugas genitales.
- E) Parotiditis viral.

5. La gota gruesa y el extendido fino sirven respectivamente para:

- A) Medir anticuerpos y vacunar.
- B) Buscar huevos y larvas.
- C) Identificar veneno y necrosis.
- D) Detectar quistes y ooquistes felinos.
- E) Aumentar sensibilidad y reconocer especie/parasitismo.

6. Una prueba rápida de malaria busca principalmente:

- A) Anticuerpos antirrábicos.
- B) Antígenos parasitarios.
- C) Huevos operculados.
- D) Cuerpos de inclusión nuclear.
- E) Toxinas de serpiente.

7. Las recaídas por hipnozoitos se asocian sobre todo con:

- A) P. falciparum y P. malariae.
- B) T. cruzi y T. rangeli.
- C) Leishmania donovani y infantum.
- D) P. vivax y P. ovale.
- E) Giardia y Trichomonas.

8. La transmisión no vectorial del paludismo puede ocurrir por:

- A) Inhalación de polvo con huevos.
- B) Contacto con verrugas.
- C) Transplacentaria o transfusional.
- D) Mordedura de gato.
- E) Carne de pescado cruda.

9. La certificación de Paraguay como país libre de malaria autóctona implica:

- A) Interrupción de transmisión local sostenida, con vigilancia continua.
- B) Ausencia mundial de malaria.
- C) Eliminación de mosquitos de todo el país.
- D) Inutilidad de todo diagnóstico en viajeros.
- E) Erradicación de Plasmodium en Brasil.

10. Una medida preventiva primaria contra paludismo es:

- A) Evitar gatos durante embarazo.
- B) Cocinar carne de cerdo.
- C) Lavar heridas por mordedura.
- D) Observar perros por 10 días.
- E) Control vectorial y protección contra picaduras.

14. Microbiología - Parasitología - Trypanosoma

Parasitología · 10 preguntas · Fuente: 3 Unidad XVI.2 Trypanosoma.pdf

1. La enfermedad de Chagas se produce por:

- A) Trypanosoma brucei gambiense.
- B) Trypanosoma rangeli exclusivamente.
- C) Leishmania infantum.
- D) Trypanosoma cruzi.
- E) Plasmodium falciparum.

2. El mecanismo vectorial principal de Chagas ocurre cuando:

- A) Heces de triatmino contaminan piel lesionada o mucosas.
- B) La vinchuca inocula larvas por saliva siempre.
- C) El mosquito Anopheles deposita ooquistes.
- D) El caracol libera cercarias al agua.
- E) La pulga transmite proglotides.

3. La forma intracélular tisular de T. cruzi es:

- A) Ooquiste.
- B) Metacercaria.
- C) Amastigote.
- D) Plerocercarioide.
- E) Hipnozoito.

4. En sangre periférica durante fase aguda de Chagas se puede buscar:

- A) Huevos mamelonados.
- B) Quistes hidatídicos.
- C) Cercarias.
- D) Pentonas.
- E) Tripomastigotes.

5. El signo de Romana se relaciona con:

- A) Ulceración nasal mucocutánea.
- B) Edema palpebral unilateral por puerta de entrada conjuntival.
- C) Vesículas en dermatoma.
- D) Mordedura de serpiente coral.
- E) Diarrea por Giardía.

6. En la fase crónica de Chagas, una complicación clásica es:

- A) Bronquiolitis por sincitios.
- B) Condiloma acuminado.
- C) Anemia megaloblástica por pescado.
- D) Cardiomiopatía dilatada y trastornos de conducción.
- E) Hidrofobia.

7. Otra manifestación digestiva crónica de Chagas es:

- A) Colitis por huevos de Schistosoma.
- B) Ictericia por Fasciola.
- C) Megaesófago o megacolon.
- D) Enteritis por rotavirus.
- E) Apendicitis por Ascaris.

8. Para diagnóstico crónico de Chagas se prefiere:

- A) Serología con pruebas diferentes.
- B) Gota gruesa única.
- C) Cinta adhesiva perianal.
- D) Cultivo de garganta.
- E) Papanicolau.

9. Trypanosoma rangeli es importante porque:

- A) Produce siempre cardiopatía mortal.
- B) Es transmitido por Anopheles.
- C) Genera quistes musculares.
- D) Causa sarcoma de Kaposi.
- E) Puede confundirse epidemiológicamente con T. cruzi y es poco patógeno.

10. La tripanosomiasis africana se asocia con:

- A) T. cruzi y vinchuca.
- B) T. brucei y mosca tsetse.
- C) Leishmania y flebotomo.
- D) Plasmodium y Anopheles.
- E) Toxoplasma y gato.

15. Microbiología - Parasitología - Toxoplasma gondii

Parasitología · 10 preguntas · Fuente: 4 Unidad XVI Toxoplasma.pdf

1. El hospedador definitivo de Toxoplasma gondii es:

- A) Felino.
- B) Humano.
- C) Mosquito.
- D) Caracol.
- E) Pez.

2. La forma invasiva y proliferativa de la fase aguda se denomina:

- A) Ooquiste esporulado.
- B) Bradyzoito tisular.
- C) Taquizoito.
- D) Metacercaria.
- E) Proglotíde.

3. Los quistes tisulares con bradizoitos se relacionan principalmente con:

- A) Fase sexual en gato únicamente.
- B) Eliminación por orina humana.
- C) Picadura de flebotomo.
- D) Huevos en vías biliares.
- E) Fase crónica y transmisión por carne.

4. Una vía frecuente de infección humana por T. gondii es:

- A) Mordedura de perro rabioso.
- B) Carne cruda o mal cocida con quistes tisulares.
- C) Picadura de vinchuca.
- D) Cercarias en agua dulce.
- E) Pescado con plerocercóide.

5. La transmisión congénita ocurre cuando:

- A) El padre tiene verrugas cutáneas.
- B) El recién nacido ingiere pescado crudo.
- C) Hay mordedura de serpiente en parto.
- D) La madre adquiere infección durante gestación o hay parasitemia relevante.
- E) Existe contacto con piojos.

6. La triada congénita clásica incluye:

- A) Parotiditis, orquitis y meningitis.
- B) Tos, fiebre y bronquiolitis.
- C) Hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis.
- D) Diarrea, meteorismo y esteatorrea.
- E) Hematuria, fibrosis vesical y cáncer.

7. En pacientes con VIH avanzado, la reactivación de toxoplasmosis suele causar:

- A) Encefalitis con lesiones cerebrales.
- B) Condilomas anogenitales.
- C) Colitis por huevos.
- D) Crisis aplásica pura.
- E) Parálisis diafrágica por veneno.

8. Para interpretar infección reciente en embarazada, es útil valorar:

- A) Cinta adhesiva perianal.
- B) Gota gruesa y gota fina.
- C) Cultivo de caracol.
- D) Prueba de coagulasa.
- E) IgM, IgG y avididad de IgG.

9. Una medida preventiva en gestantes seronegativas es:

- A) Suspender toda vacunación SRP ya recibida.
- B) Evitar carne cruda y contacto inseguro con heces de gato.
- C) Tomar antiveneno mensual.
- D) Consumir pescado crudo congelado.
- E) Caminar descalza para inmunizarse.

10. El ooquiste de Toxoplasma eliminado por felinos se vuelve importante porque:

- A) Se transforma en adulto en vía biliar.
- B) Penetra piel como larva filariforme.
- C) Forma cápside viral icosaédrica.
- D) Contamina suelo, agua o alimentos tras esporular.
- E) Produce vitamina B12.

16. Microbiología - Parasitología - Leishmania

Parasitología · 10 preguntas · Fuente: 5 Unidad XVI Leishmania.pdf

1. La forma infectante para el humano en Leishmania transmitida por flebotomo es:

- A) Amastigote intracélular.
- B) Ooquiste esporulado.
- C) Promastigote metacíclico.
- D) Cercaria acuática.
- E) Huevo embrionado.

2. Dentro del humano, Leishmania se multiplica principalmente como:

- A) Tripomastigote en eritrocitos.
- B) Merozoito en hepatocitos.
- C) Larva filariforme en piel.
- D) Procercoide en crustáceos.
- E) Amastigote en macrofagos.

3. El vector más relacionado con leishmaniasis es:

- A) Anopheles.
- B) Flebotomo.
- C) Triatomino.
- D) Caracol Lymnaea.
- E) Pulga.

4. La leishmaniasis visceral se caracteriza mejor por:

- A) Verrugas genitales y coilocitosis.
- B) Diarrea grasa sin invasión.
- C) Hidrofobia y encefalitis.
- D) Fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y pancitopenia.
- E) Prurito anal nocturno.

5. En la leishmaniasis visceral americana, un reservorio doméstico clave es:

- A) Gato como definitivo.
- B) Pez de agua dulce.
- C) Perro.
- D) Cerdo exclusivamente.
- E) Caracol.

6. La forma mucocutánea es preocupante porque puede producir:

- A) Destrucción de mucosas naso-orofaríngeas.
- B) Aplasia eritroide pura.
- C) Parálisis flácida poliomielítica.
- D) Quistes en cerebro por huevos.
- E) Bronquiolitis infantil.

7. Un diagnóstico parasitológico directo de leishmaniasis busca:

- A) Huevos mamelonados en heces.
- B) Cercarias en piel.
- C) Ooquistes ácido-alcohol resistentes.
- D) Antígenos de influenza.
- E) Amastigotes en material de lesión o médula.

8. La coinfección con VIH en leishmaniasis visceral se considera grave porque:

- A) Impide toda transmisión vectorial.
- B) Aumenta mortalidad y dificulta manejo.
- C) Convierte al parásito en virus.
- D) Elimina necesidad de tratamiento.
- E) Produce inmunidad esterilizante.

9. Una medida preventiva comunitaria correcta es:

- A) Solo clorar agua sin otras medidas.
- B) Vacunar contra HPV.
- C) Observar perros mordedores 10 días.
- D) Control del vector, reservorios y protección contra picaduras.
- E) Cocinar pescado de río.

10. La leishmaniosis se considera enfermedad desatendida porque:

- A) Afecta poblaciones vulnerables y tiene subregistro importante.
- B) Solo ocurre en países ricos.
- C) No requiere vector ni reservorio.
- D) Nunca causa daño clínico.
- E) Se erradica mundialmente.

17. Microbiología - Parasitología - Protozoarios intestinales y urogenitales

Parasitología · 10 preguntas · Fuente: 6 Unidad XVII Protozoarios intestinales y urogenitales.pdf

1. En amebas intestinales, la forma quística se caracteriza por ser:

- A) Siempre móvil e invasiva.
- B) Exclusiva de sangre.
- C) Transmitida por flebotomo.
- D) Un estadio de helminto.
- E) Resistente e infecciosa.

2. En Entamoeba histolytica, los trofozoitos se observan mejor en:

- A) Heces formadas antiguas.
- B) Heces recientes.
- C) Sangre seca.
- D) Esputo estéril.
- E) Orina matinal.

3. La presencia de trofozoitos con eritrocitos ingeridos orienta a:

- A) Entamoeba coli comensal.
- B) Giardia no invasiva.
- C) Trichomonas vaginalis.
- D) Entamoeba histolytica invasiva.
- E) Cryptosporidium.

4. Giardia lamblia produce malabsorción porque se localiza sobre todo en:

- A) Colon sigmoide exclusivo.
- B) Vías biliares adultas.
- C) Duodeno y yeyuno proximal.
- D) Ganglios sensitivos.
- E) Médula ósea.

5. Un cuadro de diarrea palida, fetida, meteorismo y pérdida de peso sugiere:

- A) Giardiasis.
- B) Rabia.
- C) Sarcoma de Kaposi.
- D) Parotiditis.
- E) Crotalismo.

6. Trichomonas vaginalis se diferencia de muchos protozoos intestinales porque:

- A) Forma huevos embrionados en suelo.
- B) Tiene reservorio felino definitivo.
- C) Necesita caracol intermediario.
- D) Es un virus de ARN.
- E) No tiene fase quística y se transmite sexualmente.

7. Balantidium coli se asocia epidemiológicamente con:

- A) Gatos y toxoplasmosis.
- B) Cerdos y cuadros disentéricos.
- C) Perros y hidatidosis.
- D) Mosquitos y dengue.
- E) Peces y B12 baja.

8. Cryptosporidium causa especial gravedad en:

- A) Adultos sanos con verrugas comunes.
- B) Pacientes con mordedura ofídica.
- C) Pescadores con anemia megaloblástica.
- D) Pacientes inmunodeprimidos con diarrea acuosa prolongada.
- E) Gestantes vacunadas contra rubéola.

9. El diagnóstico de giardiasis puede apoyarse en:

- A) Búsqueda de quistes/trofozoitos o antígenos en heces.
- B) Cuerpos de Negri en cerebro.
- C) Huevos en vía biliar.
- D) Serología de Chagas crónico.
- E) Prueba de neutralización de veneno.

10. La prevención de protozoarios intestinales prioriza:

- A) Solo repelente contra flebotomos.
- B) Vacuna SRP en adultos.
- C) Agua segura, higiene y manejo correcto de alimentos.
- D) Cocinar carne de res.
- E) Antiveneno en puestos de salud.

18. Microbiología - Parasitología - Nematodos intestinales

Parasitología · 10 preguntas · Fuente: 7 Unidad XVIII Nematodos intestinales.pdf

1. La forma infectante de *Ascaris lumbricoides* para el humano es:

- A) Larva filariforme penetrante.
- B) Huevo embrionado ingerido.
- C) Cisticerco en carne.
- D) Metacercaria en vegetal acuático.
- E) Plerocercario en pescado.

2. El síndrome de Loeffler en ascariosis se relaciona con:

- A) Adultos en vías biliares siempre.
- B) Huevos en vejiga.
- C) Cisticercos cerebrales.
- D) Migración larvaria pulmonar con eosinofilia.
- E) Toxina neurotrópica salival.

3. La obstrucción intestinal por *Ascaris* se observa sobre todo cuando:

- A) Solo hay un huevo no fecundado.
- B) El parásito está en mosquito.
- C) Existe alta carga de vermes adultos.
- D) El paciente fue vacunado contra polio.
- E) La infección es por *Trichomonas*.

4. *Trichuris trichiura* se asocia en infección intensa con:

- A) Prolapso rectal y anemia.
- B) Hidrofobia.
- C) Condiloma acuminado.
- D) Fiebre amarilla.
- E) Quiste hidatídico.

5. *Enterobius vermicularis* se diagnostica mejor mediante:

- A) Gota gruesa.
- B) Biopsia hepática.
- C) Aspirado de médula ósea.
- D) PCR respiratoria.
- E) Cinta adhesiva perianal matinal.

6. El prurito anal nocturno en un niño orienta principalmente a:

- A) Fasciolosis.
- B) Oxiuriasis.
- C) Dengue.
- D) Rabia.
- E) Leishmaniasis visceral.

7. *Strongyloides stercoralis* preocupa en inmunodeprimidos porque puede producir:

- A) Cáncer cervical.
- B) Aplasia eritroide por B19.
- C) Mononucleosis.
- D) Autoinfección e hiperinfección.
- E) Zoster localizado.

8. Uncinarias como Ancylostoma y Necator ingresan habitualmente por:

- A) Penetración cutánea de larvas filariformes.
- B) Ingestión de carne bovina cruda.
- C) Picadura de triatominos.
- D) Oocistos de gato.
- E) Mordedura de serpiente.

9. La anemia por uncinarias se debe principalmente a:

- A) Deficit de B12 por pescado.
- B) Hemolisis por malaria grave.
- C) Perdida crónica de sangre intestinal.
- D) Aplasia por parvovirus.
- E) Destrucción medular por VIH.

10. Toxocara sp. en humanos se manifiesta como:

- A) Teniasis intestinal adulta.
- B) Diarrea acuosa por coccidios.
- C) Verrugas por HPV.
- D) Parotiditis.
- E) Larva migrans visceral u ocular.

19. Microbiología - Parasitología - Cestodos

Parasitología · 10 preguntas · Fuente: 8 Unidad XIX.1 Cestodos_692844f23847639fcf5f2caca60630ff.pdf

1. *Diphyllobothrium latum* se adquiere por ingestion de:

- A) Carne de cerdo con bradizoitos.
- B) Berro con metacercarias.
- C) Agua con cercarias.
- D) Pescado crudo o poco cocido con plerocercoides.
- E) Huevos en polvo domiciliario.

2. Una complicacion clásica de *Diphyllobothrium latum* es:

- A) Hidrofobia y encefalitis.
- B) Condilomas genitales.
- C) Deficit de vitamina B12 y anemia megaloblastica.
- D) Insuficiencia respiratoria por RSV.
- E) Crisis aplasica por B19.

3. *Taenia saginata* se relaciona con:

- A) Carne bovina con cisticercos.
- B) Carne porcina con huevos embrionados.
- C) Pescado con plerocercoides.
- D) Perro con quiste hidatidico adulto.
- E) Caracol con cercarias.

4. La neurocisticercosis ocurre cuando el humano ingiere:

- A) Cisticercos de *Taenia saginata*.
- B) Plerocercoides de pescado.
- C) Metacercarias de *Fasciola*.
- D) Ooquistes de *Cryptosporidium*.
- E) Huevos de *Taenia solium*.

5. La teniasis intestinal por *T. solium* se adquiere por:

- A) Ingestion de huevos de *T. solium*.
- B) Carne de cerdo cruda o mal cocida con cisticercos.
- C) Picadura de flebotomo.
- D) Mordedura de perro.
- E) Agua con cercarias.

6. *Hymenolepis nana* es particular porque:

- A) Necesita siempre pescado y copépodo.
- B) Solo infecta perros.
- C) No produce huevos.
- D) Puede completar ciclo directo y autoinfectar.
- E) Es un trematodo hepatico.

7. *Dipylidium caninum* se transmite al humano, especialmente niños, por:

- A) Ingestion accidental de pulgas infectadas.
- B) Picadura de Anopheles.
- C) Carne bovina mal cocida.
- D) Berro contaminado.
- E) Heces de gato con ooquistes.

8. En Echinococcus granulosus, el humano actua como:

- A) Huesped definitivo principal.
- B) Vector biologico.
- C) Huesped intermediario accidental.
- D) Reservorio felino.
- E) Caracol intermediario.

9. El perro en Echinococcus granulosus alberga principalmente:

- A) Quistes hidatidicos hepaticos.
- B) Cisticercos musculares.
- C) Huevos operculados biliares.
- D) Larvas pulmonares de Ascaris.
- E) Adultos intestinales.

10. El diagnóstico de hidatidosis se apoya más en:

- A) Cinta adhesiva perianal.
- B) Imagenes y serología segun localizacion.
- C) Gota gruesa.
- D) Papanicolau.
- E) Cultivo viral.

20. Microbiología - Parasitología - Trematodos

Parasitología · 10 preguntas · Fuente: 9 Unidad XIX.2 Trematodos.pdf

1. Fasciola hepática utiliza como hospedador intermediario a:

- A) Mosquitos Aedes.
- B) Pulgas de perro.
- C) Caracoles del genero Lymnaea.
- D) Peces de agua dulce.
- E) Gatos domesticos.

2. La forma infectante de Fasciola para el humano es:

- A) Metacercaria en vegetacion acuática.
- B) Cercaria que penetra piel.
- C) Huevo embrionado en suelo.
- D) Plerocercarioide en pescado.
- E) Cisticerco en cerdo.

3. Los adultos de Fasciola hepática se localizan principalmente en:

- A) Colon.
- B) Ganglios sensoriales.
- C) Medula osea.
- D) Vejiga urinaria exclusivamente.
- E) Vias biliares.

4. Los huevos de Fasciola son eliminados al exterior por:

- A) Saliva.
- B) Heces.
- C) Orina siempre.
- D) Sudor.
- E) Semen.

5. En la fase aguda de fasciolosis predomina:

- A) Latencia neuronal.
- B) Bronquiolitis viral.
- C) Autoinfección intestinal.
- D) Migracion hepática, dolor y eosinofilia.
- E) Cisticercosis muscular.

6. Schistosoma se diferencia de Fasciola porque su cercaria:

- A) Penetra activamente la piel.
- B) Se ingiere en berros.
- C) Esta en carne de cerdo.
- D) Sale en proglotides.
- E) Permanece como quiste tisular.

7. La patologia principal de esquistosomiasis se debe sobre todo a:

- A) Toxina preformada en alimentos.
- B) Replicación en queratinocitos.
- C) Respuesta inflamatoria frente a huevos depositados.
- D) Destruccion de eritrocitos por B19.
- E) Veneno neurotoxico.

8. Schistosoma mansoni se asocia principalmente con:

- A) Hematuria terminal exclusiva.
- B) Crisis aplásica.
- C) Exantema súbito.
- D) Condilomas.
- E) Compromiso intestinal-hepático y hipertensión portal.

9. Schistosoma haematobium se relaciona con:

- A) Anemia por B12.
- B) Hematuria y riesgo de cáncer vesical.
- C) Quistes hepáticos grandes.
- D) Meningitis aseptica viral.
- E) Tos por rinovirus.

10. Los huevos de trematodos hepáticos clásicos como Fasciola suelen ser:

- A) Mamelonados de Ascaris.
- B) Con espina lateral siempre.
- C) Segmentados en proglótides.
- D) Grandes y operculados.
- E) Ácido-alcohol resistentes.

21. Microbiología - Artrópodos - Artrópodos de importancia médica

Artrópodos · 10 preguntas · Fuente: 10 Unidad XX Artrópodos.pdf

1. Una característica general de los artrópodos es:

- A) Exoesqueleto quitinoso y cuerpo segmentado.
- B) Endoesqueleto óseo y pulmones alveolares.
- C) Capsídeo icosaédrico y genoma ARN.
- D) Pared celular de peptidoglicano.
- E) Cuerpo plano sin apéndices.

2. Los insectos se diferencian de arácnidos porque suelen tener:

- A) Cuatro pares de patas y cefalotorax.
- B) Sin patas y cuerpo cilíndrico.
- C) Botrios en escolex.
- D) Ventosas oral y ventral siempre.
- E) Tres pares de patas y cuerpo en cabeza, torax y abdomen.

3. Un vector mecánico transmite agentes principalmente por:

- A) Desarrollo obligatorio del parásito en su cuerpo.
- B) Arrastre pasivo sin multiplicación del agente.
- C) Inoculación de veneno neurotóxico.
- D) Producción de huevos dentro del humano.
- E) Replicación viral en ganglio sensorial.

4. Los triatominos tienen importancia médica por transmitir:

- A) Leishmania infantum.
- B) Plasmodium vivax.
- C) Dengue virus.
- D) Trypanosoma cruzi.
- E) Fasciola hepática.

5. Los flebotomos son relevantes porque transmiten:

- A) Leishmania.
- B) Rabia.
- C) Poliovirus.
- D) Taenia saginata.
- E) Enterobius.

6. Mosquitos del género Aedes se asocian especialmente con:

- A) Chagas y leishmaniasis visceral.
- B) Hidatidosis y teniasis.
- C) Dengue, Zika, Chikungunya y fiebre amarilla urbana.
- D) Oxiuriasis y trichuriasis.
- E) Fasciolosis y esquistosomiasis.

7. La pediculosis se relaciona con infestación por:

- A) Garrapatas.
- B) Pulgas exclusivamente.
- C) Flebotomos.
- D) Cucarachas.
- E) Piojos.

8. Las garrapatas son importantes porque pueden actuar como:

- A) Huesped definitivo de Echinococcus.
- B) Vectores biologicos de varios agentes.
- C) Reservorio felino de Toxoplasma.
- D) Caracol intermediario de Fasciola.
- E) Adulto intestinal de Taenia.

9. La pulga participa en la transmisión de Dipylidium caninum cuando:

- A) Pica e inocular cercarias.
- B) Defeca tripomastigotes.
- C) Libera ooquistes en arena.
- D) Es ingerida accidentalmente con cisticercoide.
- E) Deposita huevos de Ascaris.

10. Una medida general contra vectores artrópodos en APS es:

- A) Suspender agua potable.
- B) Evitar toda vacunacion.
- C) Eliminar criaderos, usar barreras y educar a la comunidad.
- D) Usar antibioticos semanales.
- E) Capturar serpientes para estudio.

22. Microbiología - Serpientes - Importancia médica de serpientes

Serpientes · 10 preguntas · Fuente: 11 Unidad XXI Serpientes.pdf

1. En Sudamerica, la mayoría de accidentes ofídicos se atribuye a:

- A) Micrurus.
- B) Cobra.
- C) Dispholidus.
- D) Sistrurus exclusivamente.
- E) Bothrops.

2. En Paraguay, Bothrops tiene relevancia sanitaria porque:

- A) Es siempre no venenosa.
- B) Incluye especies capaces de accidentes severos.
- C) Solo causa lesiones leves locales.
- D) Pertenece a anfibios.
- E) No existe en el país.

3. Un accidente bothropico se caracteriza inicialmente por:

- A) Parálisis sin lesión local ni coagulopatía.
- B) Diarrea crónica y malabsorción.
- C) Hidrofobia y fiebre.
- D) Dolor, edema, sangrado local y alteración de coagulación.
- E) Exantema y artralgia.

4. El veneno crotalico se asocia más con:

- A) Neurotoxicidad, miotoxicidad y riesgo renal.
- B) Verrugas cutáneas.
- C) Diarrea acuosa por enterocito.
- D) Quistes hepáticos.
- E) Anemia megaloblástica.

5. Las serpientes coral del género Micrurus producen principalmente:

- A) Cuadro biliar crónico.
- B) Colitis disintérica.
- C) Cuadro neurotóxico.
- D) Bronquiolitis.
- E) Mononucleosis.

6. La conducta prehospitalaria adecuada tras mordedura sospechosa incluye:

- A) Torniquete apretado prolongado.
- B) Cortes y succión de la herida.
- C) Aplicar hielo directo por horas.
- D) Dar alcohol para analgesia.
- E) Reposo, inmovilización relativa y traslado rápido.

7. El tratamiento específico de un envenenamiento ofídico moderado o severo es:

- A) Antiviral de amplio espectro.
- B) Suero antiofídico indicado según tipo y gravedad.
- C) Albendazol por 3 días.
- D) Vacuna SRP de urgencia.
- E) Antihistamínico como única medida.

8. Para decidir gravedad y seguimiento, que estudios son más pertinentes?

- A) Papanicolau y colposcopia.
- B) Gota gruesa y gota fina exclusivamente.
- C) Coprocultivo de rutina.
- D) Coagulacion, hemograma, función renal y evaluacion local.
- E) Serologia de VEB.

9. Ante una mordedura, la identificacion de la serpiente debe:

- A) Ser obligatoria antes de todo tratamiento.
- B) Realizarse capturando siempre el animal vivo.
- C) Ayudar si es segura, pero no retrasar atención.
- D) Sustituir la evaluacion clinica.
- E) Evitar el uso de antiveneno.

10. La importancia de la guia nacional de accidentes ofidicos se relaciona con:

- A) Reducir mortalidad, secuelas y estandarizar manejo.
- B) Eliminar todos los reptiles del país.
- C) Diagnosticar virosis respiratorias.
- D) Tratar parásitosis intestinales.
- E) Reemplazar vacunacion humana.

Gabarito rápido

Las explicaciones detalladas aparecen dentro del sitio al responder cada pregunta.

1. Generalidades de Virología

1C · 2A · 3E · 4B · 5D · 6A · 7C · 8E · 9B · 10D · 11A · 12A · 13D · 14A · 15C · 16D · 17C · 18D · 19C · 20B
21C

2. Herpesvirus: VHS, VVZ, VEB, CMV, VHH-6, VHH-7 y VHH-8

1A · 2E · 3B · 4D · 5A · 6C · 7E · 8B · 9D · 10C · 11E · 12B · 13D · 14A · 15C · 16E · 17B · 18D · 19C · 20A
21D · 22B · 23C · 24A · 25A · 26A · 27B · 28B · 29B · 30A · 31C · 32D · 33D · 34C · 35D · 36B · 37A · 38C · 39C · 40D
41D · 42A · 43B · 44B · 45A

3. Papilomavirus

1B · 2D · 3A · 4C · 5E · 6B · 7D · 8C · 9A · 10E · 11B · 12C · 13C · 14A · 15C · 16D · 17A · 18C · 19A · 20A
21B · 22B · 23B · 24D · 25A · 26A · 27A · 28C · 29B · 30B · 31A · 32D · 33B

4. Adenovirus

1D · 2A · 3C · 4E · 5B · 6D · 7C · 8A · 9E · 10B · 11A · 12D · 13D · 14B · 15D · 16B · 17B · 18C · 19A · 20D
21B · 22D · 23B · 24B · 25B · 26A · 27A · 28B · 29C · 30C · 31C

5. Parvovirus y Poxvirus

1A · 2C · 3E · 4B · 5D · 6C · 7A · 8E · 9B · 10D · 11D · 12D · 13D · 14A · 15D · 16B · 17C · 18C · 19A · 20B
21C · 22D · 23A · 24A · 25C · 26B · 27B · 28C · 29B · 30C · 31B · 32B · 33A · 34A · 35B · 36D · 37D · 38B

6. Picornavirus

1C · 2E · 3B · 4D · 5C · 6A · 7E · 8B · 9D · 10A

7. Orthomixovirus y Reovirus

1E · 2B · 3D · 4C · 5A · 6E · 7B · 8D · 9A · 10C

8. Paramixovirus

1B · 2D · 3C · 4A · 5E · 6B · 7D · 8A · 9C · 10E

9. Rhabdovirus

1D · 2C · 3A · 4E · 5B · 6D · 7A · 8C · 9E · 10B

10. Togavirus y Flavivirus

1C · 2A · 3E · 4B · 5D · 6A · 7C · 8E · 9B · 10D

11. Retrovirus

1A · 2E · 3B · 4D · 5A · 6C · 7E · 8B · 9D · 10C

12. Generalidades, huéspedes y prevención

1E · 2B · 3D · 4A · 5C · 6E · 7B · 8D · 9C · 10A

13. Paludismo

1B · 2D · 3A · 4C · 5E · 6B · 7D · 8C · 9A · 10E

14. Trypanosoma

1D · 2A · 3C · 4E · 5B · 6D · 7C · 8A · 9E · 10B

15. Toxoplasma gondii

1A · 2C · 3E · 4B · 5D · 6C · 7A · 8E · 9B · 10D

16. Leishmania

1C · 2E · 3B · 4D · 5C · 6A · 7E · 8B · 9D · 10A

17. Protozoarios intestinales y urogenitales

1E · 2B · 3D · 4C · 5A · 6E · 7B · 8D · 9A · 10C

18. Nematodos intestinales

1B · 2D · 3C · 4A · 5E · 6B · 7D · 8A · 9C · 10E

19. Cestodos

1D · 2C · 3A · 4E · 5B · 6D · 7A · 8C · 9E · 10B

20. Trematodos

1C · 2A · 3E · 4B · 5D · 6A · 7C · 8E · 9B · 10D

21. Artrópodos de importancia médica

1A · 2E · 3B · 4D · 5A · 6C · 7E · 8B · 9D · 10C

22. Importancia médica de serpientes

1E · 2B · 3D · 4A · 5C · 6E · 7B · 8D · 9C · 10A